

PERATURAN DIREKTUR PERSEROAN TERBATAS DISA PRIMA MEDIKA
NOMOR: 823.3/DPM/I-PER/DIR/XII/2024

TENTANG
PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT
(HOSPITAL BY-LAWS)

DIREKTUR PERSEROAN TERBATAS DISA PRIMA MEDIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola korporasi yang baik (*Good Corporate Governance*) dan tata kelola klinis yang baik (*Good Clinical Governance*), diperlukan peraturan internal yang mengatur hubungan, hak, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab antara Pemilik, Pengelola, dan Tenaga medis;
- b. bahwa sehubungan dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, perlu dilakukan penyesuaian tata kelola rumah sakit guna menjamin kepastian hukum, mutu pelayanan, dan keselamatan pasien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan di Rumah Sakit
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*)
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR PT. DISA PRIMA MEDIKA TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (HOSPITAL BY-LAWS)**

BAB I
KETENTUAN UMUM**Pasal 1**
Definisi

Dalam Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) adalah aturan dasar yang mengatur tata cara penyelenggaraan rumah sakit secara keseluruhan, yang terdiri dari Tata Kelola Korporasi (*Corporate Bylaws*) dan Tata Kelola Klinis (*Medical Staff Bylaws*).
- (2) Peraturan Internal Korporasi (*Corporate Bylaws*) adalah aturan yang mengatur tata kelola korporasi (*corporate governance*) melalui penetapan struktur organisasi, wewenang, dan hubungan kerja antara Pemilik, Representasi Pemilik, dan Direksi/Pejabat Pengelola Rumah Sakit.
- (3) Peraturan Internal Tenaga medis (*Medical Staff Bylaws*) adalah aturan yang mengatur tata kelola klinis (*clinical governance*) guna menjaga profesionalisme dan mutu pelayanan yang diberikan oleh Tenaga medis di Rumah Sakit.
- (4) Pemilik/Badan Hukum adalah pihak yang memiliki dan menaungi Rumah Sakit, dalam hal ini adalah Perseroan Terbatas Disa Prima Medika
- (5) Representasi Pemilik adalah organ yang mewakili Pemilik untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Rumah Sakit oleh Direksi serta memberikan nasihat dalam menjalankan kegiatan operasional.
- (6) Direktur Rumah Sakit adalah pejabat pengelola tertinggi yang memimpin, bertanggung jawab, dan bertugas terhadap keberlangsungan operasional Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo, baik secara teknis medis maupun teknis operasional.
- (7) Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah perangkat non-struktural yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal guna membantu Direktur dalam meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, ketaatan terhadap peraturan, serta tanggung jawab sosial (*Social Responsibility*).
- (8) Komite Medis adalah perangkat non-struktural yang dibentuk untuk menerapkan tata kelola klinis (*clinical governance*) melalui mekanisme Kredensial, penjagaan mutu profesi, serta pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
- (9) Komite Etik dan Hukum adalah wadah non-struktural yang bertugas memberikan pertimbangan atau rekomendasi kepada Direktur terkait penyusunan kebijakan medikoetikolegal, etika pelayanan, penyelesaian masalah etika, dan bantuan hukum.
- (10) Komite Keperawatan adalah perangkat non-struktural yang dibentuk oleh Direktur untuk menyelenggarakan tata kelola klinis keperawatan melalui mekanisme kredensial, pemeliharaan mutu profesi, pengembangan profesional berkelanjutan, serta pembinaan etika dan disiplin profesi keperawatan.
- (11) Komite Tenaga Kesehatan Lain (KTKL) adalah perangkat non-struktural yang dibentuk oleh Direktur untuk menyelenggarakan tata kelola profesi tenaga kesehatan selain tenaga medis dan tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, pemeliharaan mutu profesi, pengembangan kompetensi, serta pembinaan etika dan disiplin profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Sub Komite adalah kelompok kerja di bawah Komite Medis atau komite lainnya yang dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur untuk melaksanakan fungsi tertentu dari Komite Induk.
- (13) Staf Medis Fungsional (SMF) adalah kelompok dokter dan/atau dokter spesialis yang melaksanakan pelayanan medis dan telah diterima sesuai dengan Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.
- (14) Dokter adalah dokter dan/atau dokter spesialis yang memiliki izin dan Penugasan Klinis untuk melakukan pelayanan di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.

- (15) Pelayanan Medis adalah pelayanan individual yang diberikan oleh tenaga medis berupa pemeriksaan, konsultasi, dan tindakan medis kepada pasien.
- (16) Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis, terapi, dan fungsi penunjang lainnya.
- (17) Pelayanan Keperawatan adalah upaya pelayanan profesional yang diberikan oleh tenaga keperawatan untuk membantu pasien dalam memenuhi kebutuhan dasar dan mencapai kesehatan yang optimal.
- (18) Kredensial (Credentialing) adalah proses evaluasi secara menyeluruh terhadap tenaga medis, tenaga keperawatan, dan tenaga kesehatan lainnya untuk menentukan kelayakan pemberian Kewenangan Klinis (Clinical Privilege) sesuai kompetensi, kewenangan, dan lingkup praktik profesinya.
- (19) Rekredensial (Recredentialing) adalah proses evaluasi ulang secara berkala terhadap tenaga medis, tenaga keperawatan, dan tenaga kesehatan lainnya yang telah memiliki Kewenangan Klinis untuk menentukan kelayakan perpanjangan, perubahan, pembatasan, atau pencabutan kewenangan tersebut sesuai dengan kompetensi dan kinerja profesionalnya.
- (20) Kewenangan Klinis (Clinical Privilege) adalah hak khusus yang diberikan kepada tenaga medis, tenaga keperawatan, dan tenaga kesehatan lainnya untuk melakukan sekelompok pelayanan klinis tertentu di lingkungan Rumah Sakit sesuai dengan kompetensi, kewenangan profesi, serta berdasarkan Penugasan Klinis (Clinical Appointment) yang diberikan oleh Direktur.
- (21) Penugasan Klinis (Clinical Appointment) adalah surat keputusan formal yang ditetapkan oleh Direktur kepada tenaga medis, tenaga keperawatan, dan tenaga kesehatan lainnya untuk melaksanakan pelayanan klinis sesuai dengan Kewenangan Klinis (Clinical Privilege) yang telah diberikan berdasarkan hasil kredensial dan/atau rekredensial.
- (22) Audit Medis (Medical Audit) adalah evaluasi profesional terhadap mutu pelayanan medis melalui analisis rekam medis yang dilaksanakan oleh profesi medis melalui Komite Medis.
- (23) Rapat Rutin Representasi Pemilik adalah setiap rapat terjadwal yang diselenggarakan oleh Representasi Pemilik, di luar Rapat Tahunan dan Rapat Khusus.
- (24) Rapat Tahunan Representasi Pemilik adalah rapat yang diselenggarakan oleh Pemilik atau Representasi Pemilik setahun sekali untuk mengevaluasi kinerja dan kebijakan umum Rumah Sakit.
- (25) Rapat Khusus Representasi Pemilik adalah rapat yang diselenggarakan sewaktu-waktu di luar jadwal rutin untuk mengambil keputusan mengenai hal-hal yang bersifat mendesak.

BAB II PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT

Pasal 2 Nama dan Kedudukan

Rumah Sakit ini bernama

- (1) Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yang berkedudukan di Jl. Raya Surabaya – Malang Km 54, Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo – Pasuruan.

Pasal 3 Tujuan, Visi, Misi dan Dasar Pelayanan

Penyelenggaraan Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Visi: Menjadi rumah sakit berkualitas prima yang menjadi pilihan utama bagi seluruh lapisan masyarakat.
- (2) Misi:
 - a. Memberikan pelayanan kesehatan yang aman, tepat, cepat, dan akurat;
 - b. Mengutamakan kepuasan dan keselamatan pasien;
 - c. Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan.
- (3) Falsafah: Memberikan pelayanan secara profesional berlandaskan hati nurani yang berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien.
- (4) Motto Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo adalah “Sahabat Menuju Sehat”
- (5) Tujuan:
 - a. Tujuan Umum: Mewujudkan derajat kesehatan pasien secara optimal melalui proses pelayanan yang prima, profesional, paripurna, dan terjangkau, guna memenuhi harapan masyarakat serta meningkatkan sumber daya manusia yang berkomitmen tinggi bagi kemajuan Rumah Sakit.
 - b. Tujuan Khusus:
 - 1) Memberikan pelayanan medis spesialistik yang lengkap dan terjangkau;
 - 2) Memberikan pelayanan rujukan spesialistik yang profesional;
 - 3) Memberikan pelayanan kesehatan yang tepat waktu, tepat sarana, dan penuh empati;
 - 4) Menurunkan angka kematian di Rumah Sakit;
 - 5) Mewujudkan kepuasan pasien dan kesejahteraan seluruh karyawan Rumah Sakit.
- (6) Dasar Pelayanan (7 Nilai Budi Utama)
Penyelenggaraan pelayanan didasarkan pada nilai-nilai:
 - a. Jujur;
 - b. Tanggung Jawab;
 - c. Visioner;
 - d. Disiplin;
 - e. Kerja Sama;
 - f. Adil; dan
 - g. Peduli.

Pasal 4

Tugas, Pokok dan Fungsi Rumah Sakit

Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna dengan fungsi sebagai berikut:

- (1) Memberikan pelayanan kesehatan yang profesional dan komprehensif guna mewujudkan pelayanan prima serta paripurna bagi seluruh pasien.
- (2) Melaksanakan pelayanan penunjang medis dan penunjang umum secara terintegrasi untuk mendukung efektivitas diagnosis dan kenyamanan operasional rumah sakit.
- (3) Mengelola Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS), penyelenggaraan rekam medis yang akurat, serta pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan penelitian.
- (4) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian internal terhadap pengelolaan sumber daya serta operasional pelayanan sesuai dengan standar rumah sakit yang berlaku.
- (5) Menyelenggarakan urusan administrasi, ketatausahaan, dan urusan dalam untuk mendukung kelancaran seluruh kegiatan operasional rumah sakit.

Pasal 5
Asas Pelayanan

- (1) Transparansi merupakan asas keterbukaan yang menjamin kebebasan arus informasi sehingga pihak yang membutuhkan dapat mengakses informasi relevan secara langsung
- (2) Akuntabilitas mencakup kejelasan fungsi, struktur, dan sistem pengelolaan rumah sakit agar seluruh kinerja organisasi dapat dipertanggungjawabkan secara terukur
- (3) Responsibilitas adalah bentuk kepatuhan pengelolaan organisasi terhadap prinsip pelayanan kesehatan yang sehat, etika profesi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (4) Independensi mencerminkan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional yang bebas dari benturan kepentingan maupun tekanan dari pihak manapun

BAB III
PENGORGANISASIAN RUMAH SAKIT DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 6
Pengorganisasian

- (1) Struktur Organisasi menetapkan pembagian posisi jabatan, tugas, fungsi, tanggung jawab, serta wewenang yang jelas di dalam organisasi guna menjamin kepastian tata kelola
- (2) Prosedur Kerja mengatur hubungan dan mekanisme kerja antarposisi jabatan serta fungsi organisasi untuk menjamin koordinasi yang terpadu dan sistematis
- (3) Pengelompokan Fungsi Pelayanan menetapkan pembagian fungsi yang tegas dengan menerapkan prinsip pengendalian internal guna menjamin efektivitas pencapaian tujuan organisasi
- (4) Pengelolaan Sumber Daya Manusia menetapkan kebijakan dan pengaturan sumber daya manusia yang transparan serta akuntabel yang berorientasi pada pemenuhan tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan produktif

Pasal 7
Struktur Organisasi

- (1) Pengawas dan Direksi Rumah Sakit
 - a. Representasi Pemilik
 - b. Direktur
 - c. Kepala Bidang
 - d. Satuan Pengawas Internal (SPI)
 - e. Sekretariat
 - f. PIPP
- (2) Bidang Pelayanan Medik
 - a. Instalasi Rawat Inap (IRNA, Maternitas, Neonatologi)
 - b. Intensive Care Unit (ICU, NICU, HCU dan PICU)
 - c. Instalasi Rawat Jalan
 - d. Instalasi Gawat Darurat
 - e. Instalasi Kamar Operasi
- (3) Bidang Penunjang
 - a. Instalasi Laboratorium
 - b. Instalasi Radiologi
 - c. Instalasi Farmasi
 - d. Instalasi Rekam Medis & Pendaftaran
 - e. Instalasi Gizi

- f. Instalasi CSSD
- g. Laundry
- (4) Bagian Umum
 - a. Asuransi Center
 - b. SDM dan Diklat
 - c. Humas & Marketing
 - d. IPSRS
 - e. IT & SIMRS
 - f. Gudang Umum
 - g. Operasional Lapangan (Driver, Security, Parkir, Pemulasaran Jenazah, dan Cleaning Service)
- (5) Komite dan Tim Khusus
 - a. Komite (Medik, Keperawatan, Tenaga Kesehatan Lain, Farmasi & Terapi, PPRA, PMKP, K3RS, PPI, dan Etik)
 - b. Tim (PKRS, Stunting, HTA, PONEK, TB DOTS, HIV, Geriatri, PKBRS, dan Anti Fraud)

Pasal 8 Prinsip Tata Kelola

- (1) Struktur Organisasi
Penyusunan kerangka hierarki yang jelas untuk menentukan alur tanggung jawab dan wewenang di lingkungan rumah sakit.
- (2) Prosedur Kerja
 - a. Direktur wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan internal RS Prima Husada Sukorejo Sukorejo maupun dengan unit di bawah naungan PT Disa Prima Medika
 - b. Kepala Bidang (Pelayanan Medis, Penunjang Medis, dan Umum) serta Kepala Komite Medis bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, serta memberikan bimbingan dan petunjuk teknis kepada bawahannya.
 - c. Setiap laporan yang diterima dari bawahan wajib diolah oleh Kepala Bidang/Komite terkait sebagai bahan penyusunan laporan lanjutan dan dasar pemberian instruksi kepada staf.
 - d. Para Kepala Bidang dan Kepala Komite Medis wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Direktur Rumah Sakit.
 - e. Seluruh Kepala Bidang dan Kepala Komite Medis wajib menjaga koordinasi lintas sektoral dalam pelaksanaan tugas.
 - f. Setiap pimpinan unit/Instalasi wajib mengadakan evaluasi kinerja secara rutin dan melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi tersebut.
- (3) Pengelompokan Fungsi Pelayanan
Pengorganisasian layanan kesehatan berdasarkan jenis dan spesialisasi untuk efisiensi operasional.
- (4) Pengelompokan Sumber Daya Manusia
Pemetaan dan penempatan staf berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kebutuhan organisasi.

BAB IV REPRESENTASI PEMILIK

Pasal 9

Definisi

- (1) Representasi Pemilik adalah seseorang, atau pengurus yang ditunjuk secara resmi oleh Pemilik RS (Komisaris) untuk mewakili kepentingan mereka dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan rumah sakit yang dijalankan oleh Direksi RS.
- (2) Representasi Pemilik ditetapkan oleh Pemilik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dokumen tata kelola perusahaan yang berlaku.
- (3) Organisasi Representasi Pemilik berkedudukan sebagai organisasi yang terpisah dari struktur organisasi operasional rumah sakit dan bertanggung jawab kepada Pemilik (Komisaris).
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Representasi Pemilik melakukan komunikasi, koordinasi, pengawasan, serta evaluasi terhadap kinerja Direktur Rumah Sakit sesuai kewenangan yang diberikan oleh Pemilik.

Pasal 10

Kualifikasi Representasi Pemilik

- (1) Memiliki integritas, moral, dan etika yang baik.
- (2) Memiliki kompetensi di bidang manajemen, kesehatan, hukum, atau keuangan.
- (3) Memahami tata kelola dan penyelenggaraan rumah sakit.
- (4) Mampu melaksanakan fungsi pengawasan secara independen dan objektif.
- (5) Tidak merangkap sebagai Direktur atau pejabat struktural operasional rumah sakit.
- (6) Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
- (7) Kepatuhan pada persyaratan tambahan yang ditetapkan secara khusus oleh pemilik Rumah Sakit

Pasal 11

Pengangkatan, Penilaian dan Pemberhentian

- (1) Masa jabatan Representasi Pemilik ditetapkan selama 2 (dua) tahun dan dapat ditetapkan kembali berdasarkan hasil evaluasi kinerja serta keputusan Pemilik Rumah Sakit.
- (2) Waktu pengangkatan dilakukan secara tidak bersamaan dengan waktu pengangkatan pejabat pengelola rumah sakit
- (3) Pemberhentian sebelum masa jabatan berakhir dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh pihak pemilik sesuai ketentuan yang berlaku
- (4) Penilaian kinerja secara berkala dilakukan oleh pemilik terhadap Representasi Pemilik minimal setiap 1 (Satu) tahun sekali dan hasil evaluasinya didokumentasikan.
- (5) Pemberhentian Representasi Pemilik oleh Pemilik dilakukan jika :
 - a. Terdapat pelanggaran hukum atau tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - b. Terlibat dalam tindakan yang merugikan pihak rumah sakit atau Pemilik

Pasal 12

Uraian Tugas Representasi Pemilik

- (1) Menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;
- (2) Menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
- (3) Menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
- (4) Mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya dalam penyelenggaraan pelayanan;
- (5) Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;

- (6) Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit; dan
- (7) Mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan;

Pasal 13

Tanggung Jawab Representasi Pemilik

- (1) Menyetujui, menetapkan visi misi rumah sakit sesuai arahan Pemilik dan mengkaji secara periodik serta memastikan bahwa masyarakat mengetahui visi, misi rumah sakit.
- (2) Menyetujui berbagai strategi dan rencana operasional rumah sakit yang diperlukan untuk berjalannya rumah sakit sehari-hari.
- (3) Menyetujui partisipasi rumah sakit dalam pendidikan profesional kesehatan dan dalam penelitian serta mengawasi mutu dari program-program tersebut.
- (4) Menyetujui dan menyediakan modal serta dana operasional dan sumber daya lain yang diperlukan untuk menjalankan rumah sakit dan memenuhi misi serta rencana strategis rumah sakit.
- (5) Melakukan evaluasi tahunan kinerja Direksi dengan menggunakan proses dan kriteria yang telah ditetapkan.
- (6) Mendukung peningkatan mutu dan keselamatan pasien dengan menyetujui program peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
- (7) Melakukan pengkajian laporan hasil pelaksanaan program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) setiap 3 (tiga) bulan sekali serta memberikan umpan balik perbaikan yang harus dilaksanakan dan hasilnya di evaluasi kembali pada pertemuan berikutnya secara tertulis.
- (8) Melakukan pengkajian laporan Manajemen Risiko setiap 6 (enam) bulan sekali dan memberikan umpan balik perbaikan yang harus dilaksanakan dan hasilnya di evaluasi kembali pada pertemuan berikutnya secara tertulis.

Pasal 14

Wewenang Representasi Pemilik

- (1) Menetapkan dan mengesahkan visi, misi, nilai-nilai, serta arah strategis rumah sakit sesuai dengan kebijakan Pemilik.
- (2) Meminta, menerima, dan melakukan kajian terhadap laporan berkala mengenai pelaksanaan visi, misi, rencana strategis, dan kinerja rumah sakit.
- (3) Memberikan persetujuan, arahan, dan evaluasi terhadap strategi, kebijakan, rencana bisnis, rencana kerja, dan rencana operasional rumah sakit.
- (4) Meminta data, informasi, dan dokumen yang diperlukan dari Direksi atau unit terkait dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dan evaluasi.
- (5) Memberikan persetujuan atas penyelenggaraan program pendidikan tenaga kesehatan, pelatihan, penelitian, dan kegiatan akademik lainnya yang dilaksanakan oleh rumah sakit.
- (6) Menetapkan kebijakan penyediaan modal, pendanaan, serta sumber daya yang diperlukan untuk mendukung operasional rumah sakit sesuai kemampuan dan ketentuan yang berlaku.
- (7) Melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja Direksi berdasarkan indikator, kriteria, dan mekanisme yang telah ditetapkan.
- (8) Memberikan arahan, rekomendasi, dan keputusan terkait upaya peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
- (9) Meminta dan mengkaji laporan pelaksanaan Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) secara berkala serta menetapkan tindak lanjut yang diperlukan.

- (10) Meminta dan mengkaji laporan Manajemen Risiko secara berkala serta memberikan arahan dan rekomendasi perbaikan untuk memitigasi risiko organisasi.
- (11) Meminta pelaksanaan tindakan korektif dan preventif atas hasil evaluasi, audit, kajian mutu, maupun pengelolaan risiko serta melakukan pemantauan terhadap pelaksanaannya.
- (12) Menghadiri atau meminta penyelenggaraan rapat koordinasi dengan Direksi dan unsur manajemen untuk membahas kinerja, mutu, keselamatan pasien, dan pengelolaan risiko rumah sakit.

BAB V DIREKTUR RUMAH SAKIT

Pasal 15 Kualifikasi Direktur

- (1) Kualifikasi profesi tenaga kesehatan yang memiliki keahlian, integritas, jiwa kepemimpinan, serta pengalaman yang memadai di bidang perumahsakit
- (2) Latar belakang pendidikan formal minimal pascasarjana S2 Magister Manajemen, Magister Administrasi Rumah Sakit (MARS), atau bidang magister kesehatan lainnya yang relevan
- (3) Mempunyai pengalaman di Rumah Sakit minimal 2 tahun
- (4) Legalitas profesi yang valid dibuktikan dengan kepemilikan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) yang masih berlaku
- (5) Rekam jejak dan dedikasi profesional yang baik serta memiliki komitmen kuat untuk mengembangkan usaha guna mencapai kemandirian Rumah Sakit
- (6) Kecakapan hukum sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum serta tidak pernah menjadi pemimpin perusahaan yang dinyatakan pailit
- (7) Komitmen praktik bisnis sehat yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menjalankan tata kelola bisnis yang transparan dan akuntabel
- (8) Kompetensi manajemen strategis dalam mengelola sumber daya manusia, keuangan, dan operasional rumah sakit secara efektif
- (9) Pemahaman regulasi kesehatan yang mendalam mengenai perundang-undangan serta standar akreditasi rumah sakit yang berlaku di Indonesia
- (10) Kemampuan komunikasi dan negosiasi yang baik untuk menjalin hubungan dengan pemangku kepentingan, mitra bisnis, maupun instansi pemerintah
- (11) Bebas dari benturan kepentingan dengan tidak menjabat posisi strategis di lembaga lain yang dapat mengganggu independensi dalam memimpin rumah sakit

Pasal 16 Pengangkatan, Penilaian dan Pemberhentian

- (1) Otoritas pengangkatan dan pemberhentian Direktur Rumah Sakit berada sepenuhnya di tangan Direktur Perseroan Terbatas yang ditetapkan melalui Surat Keputusan resmi
- (2) Masa bakti jabatan Direktur ditetapkan selama 3 tahun dan dapat diperpanjang kembali melalui ketetapan Surat Keputusan Direktur Perseroan Terbatas
- (3) Proses penilaian kinerja Direktur dilaksanakan secara berkala setiap 1 tahun sekali oleh pemilik atau pihak representasi pemilik
- (4) Kriteria evaluasi jabatan didasarkan pada pencapaian target kerja, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas pengelolaan operasional dan keuangan rumah sakit
- (5) Mekanisme pemberhentian sebelum masa jabatan berakhir dapat dilakukan apabila Direktur melanggar peraturan internal, tidak mencapai standar kinerja, atau terlibat tindakan yang merugikan institusi

- (6) Penetapan status definitif bagi Direktur yang diperpanjang masa jabatannya wajib melalui tinjauan ulang terhadap hasil penilaian kinerja tahunan

Pasal 17
Uraian Tugas Direktur

- (1) Kepemimpinan operasional perusahaan dilaksanakan dengan memimpin dan mengelola rumah sakit sesuai dengan Undang-Undang, regulasi yang berlaku, serta anggaran dasar perusahaan
- (2) Pelaksanaan fungsi manajemen menyeluruh mencakup perencanaan strategis, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, pengarahan staf, serta pengendalian aktivitas rumah sakit termasuk kebijakan pengendalian anti korupsi antara lain kebijakan fraud di lingkungan rumah sakit
- (3) Penyusunan rekomendasi kebijakan strategis yang diajukan kepada Representasi Pemilik sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan tingkat tinggi
- (4) Sosialisasi visi dan misi rumah sakit kepada publik guna membangun citra instansi dan memastikan keterbukaan informasi kepada masyarakat
- (5) Pengesahan anggaran dan pengembangan bisnis meliputi persetujuan rancangan keuangan tahunan, rencana pengembangan kompetensi SDM, serta proposal penyesuaian kompensasi kemitraan dokter spesialis dan remunerasi karyawan
- (6) Manajemen hubungan eksternal dilakukan dengan memelihara serta merespons secara harmonis hubungan dengan instansi pemerintah, pihak swasta, dan organisasi terkait demi kemajuan perusahaan
- (7) Penjaminan mutu pelayanan melalui pengawasan standar operasional prosedur agar selaras dengan keselamatan pasien dan kepuasan pemangku kepentingan
- (8) Pengelolaan manajemen risiko organisasi dengan melakukan identifikasi serta mitigasi terhadap potensi kendala dalam operasional harian maupun jangka panjang

Pasal 18
Tanggung Jawab Direktur

- (1) Mematuhi perundang-undangan yang berlaku
- (2) Menjalankan visi dan misi rumah sakit yang telah ditetapkan.
- (3) Menetapkan kebijakan rumah sakit, termasuk kebijakan pengendalian anti korupsi antara lain kebijakan fraud di lingkungan rumah sakit.
- (4) Memberikan tanggapan terhadap setiap laporan pemeriksaan yang dilakukan oleh regulator.
- (5) Mengelola dan mengendalikan sumber daya manusia, keuangan dan sumber daya lainnya
- (6) Merekomendasikan sejumlah kebijakan, rencana strategis, dan anggaran kepada Representatif pemilik/Representasi Pemilik untuk mendapatkan persetujuan
- (7) Menetapkan prioritas perbaikan Tingkat rumah sakit yaitu perbaikan yang akan berdampak luas/menyeluruh di rumah sakit yang akan dilakukan pengukuran sebagai indikator mutu prioritas rumah sakit
- (8) Melaporkan hasil pelaksanaan program mutu dan keselamatan pasien meliputi pengukuran data dan laporan semua insiden keselamatan pasien secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Representasi pemilik/Representasi Pemilik .
- (9) Melaporkan hasil pelaksanaan program manajemen risiko kepada Representasi pemilik/Representasi Pemilik setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 19
Wewenang Direktur

- (1) Kepemimpinan operasional strategis dalam mengelola rumah sakit untuk senantiasa meningkatkan daya guna serta hasil guna sesuai dengan tujuan institusi
- (2) Pelaksanaan kebijakan pengembangan usaha sesuai dengan garis besar haluan yang telah ditetapkan oleh pihak Pemilik atau Direktur Utama
- (3) Pengendalian operasional berbasis lingkungan guna memastikan seluruh aktivitas rumah sakit memiliki wawasan dan kepatuhan terhadap standar lingkungan
- (4) Pelaporan kinerja secara periodik baik berupa laporan tahunan maupun laporan berkala termasuk laporan mutu dan laporan pelaksanaan program manajemen resiko kepada pihak Perseroan Terbatas
- (5) Manajemen aset institusi yang mencakup kewenangan penuh untuk menggunakan, memelihara, serta mengelola seluruh aset milik rumah sakit
- (6) Representasi hukum organisasi dengan mewakili rumah sakit baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam segala urusan hukum
- (7) Penetapan kebijakan anggaran yang meliputi pengelolaan modal serta dana operasional rumah sakit secara akuntabel
- (8) Pengembangan profesionalisme kesehatan melalui kewenangan menetapkan kebijakan, prosedur, serta persetujuan program pendidikan dan penelitian bagi tenaga medis
- (9) Penyusunan rencana strategis yang mencakup penyiapan Rencana Jangka Panjang (RJP) serta Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) rumah sakit
- (10) Penyelenggaraan administrasi keuangan dengan mengadakan dan memelihara pembukuan sesuai standar akuntansi yang berlaku umum bagi rumah sakit
- (11) Manajemen sumber daya manusia kontrak yang meliputi kewenangan mengangkat, memberhentikan, serta menetapkan hak dan kewajiban tenaga kontrak sesuai regulasi
- (12) Otoritas kepegawaian tetap dan klinis dalam mengangkat atau memberhentikan dokter, dokter spesialis, dan pegawai tetap sesuai peraturan perundang-undangan
- (13) Penetapan kesejahteraan pegawai melalui pengaturan hak dan kewajiban bagi dokter, dokter spesialis, serta seluruh staf rumah sakit
- (14) Delegasi wewenang persetujuan kepada pejabat di bawahnya guna kelancaran birokrasi dan pengambilan keputusan di lingkungan rumah sakit
- (15) Pembentukan struktur pembantu pimpinan dalam menjalankan tugas harian melalui koordinasi dengan para Kepala Bidang atau Kepala Bagian

BAB VI

SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI)

Pasal 20

Organisasi SPI

- (1) Kedudukan Satuan Pengawas Internal merupakan unit kerja fungsional yang berkedudukan langsung di bawah Direktur untuk membantu pelaksanaan pengawasan internal rumah sakit
- (2) Independensi SPI dilakukan dengan memastikan tim pengawas bekerja secara objektif dan bebas dari pengaruh operasional unit kerja yang diperiksa
- (3) Struktur organisasi SPI terdiri dari ketua merangkap anggota, sekretaris, dan anggota yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur
- (4) Kualifikasi personil SPI wajib memiliki kompetensi di bidang audit, manajemen keuangan, serta pemahaman mendalam mengenai operasional perumahsakit
- (5) Fungsi pengawasan internal mencakup audit kinerja, audit keuangan, serta evaluasi kepatuhan terhadap prosedur operasional standar dan peraturan perundang-undangan

- (6) Akses data dan informasi diberikan secara penuh kepada SPI untuk memeriksa dokumen, catatan, fisik aset, serta meminta keterangan dari seluruh unit kerja di rumah sakit
- (7) Mekanisme pelaporan SPI dilakukan dengan menyampaikan laporan hasil audit secara berkala serta rekomendasi perbaikan langsung kepada Direktur
- (8) Tindak lanjut hasil audit wajib dilaksanakan oleh unit kerja terkait berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh SPI dan dipantau pelaksanaannya secara konsisten
- (9) Koordinasi dengan auditor eksternal dilakukan apabila diperlukan guna sinkronisasi data dan kelancaran proses pemeriksaan oleh pihak luar atau regulator

Pasal 21
Kualifikasi SPI

- (1) Integritas dan moralitas tinggi serta kejujuran dalam melaksanakan tugas pengawasan tanpa adanya pengaruh dari pihak lain
- (2) Kompetensi pendidikan formal minimal sarjana (S1) di bidang Akuntansi, Keuangan, Manajemen, atau bidang lain yang relevan dengan operasional rumah sakit
- (3) Pemahaman tata kelola rumah sakit secara mendalam mencakup aspek klinis, manajemen risiko, serta regulasi perumahnya sakit yang berlaku
- (4) Keahlian dalam teknik audit yang meliputi kemampuan analisis data, pemeriksaan kepatuhan, serta evaluasi pengendalian internal
- (5) Sertifikasi profesional seperti Certified Internal Auditor (CIA) atau sertifikasi audit internal lainnya yang menjadi nilai tambah bagi objektivitas kerja
- (6) Pengalaman kerja yang memadai di bidang pengawasan atau audit minimal selama jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pihak manajemen
- (7) Kecakapan komunikasi profesional untuk menyampaikan temuan audit dan rekomendasi perbaikan secara lisan maupun tertulis kepada Direksi
- (8) Bebas dari benturan kepentingan dengan tidak merangkap jabatan operasional lain yang dapat mengganggu independensi dalam menjalankan fungsi audit
- (9) Ketajaman berpikir analitis dalam mengidentifikasi potensi penyimpangan, inefisiensi, serta risiko dalam pengelolaan aset rumah sakit
- (10) Kepribadian yang objektif dalam menilai fakta-fakta lapangan tanpa bersifat subjektif atau memiliki keterikatan personal dengan unit yang diaudit

Pasal 22
Pengangkatan, Penilaian dan Pemberhentian

- (1) Otoritas pengangkatan anggota SPI dilakukan oleh Direktur Rumah Sakit dan ditetapkan melalui Surat Keputusan resmi
- (2) Masa jabatan personil SPI ditetapkan untuk jangka waktu tertentu (biasanya 3 tahun) dan dapat diangkat kembali sesuai dengan kebijakan manajemen
- (3) Struktur keanggotaan SPI terdiri dari unsur tenaga ahli atau staf yang memiliki kompetensi audit dan tidak sedang menjabat posisi manajerial operasional lainnya
- (4) Proses penilaian kinerja berkala dilakukan oleh Direktur terhadap efektivitas hasil audit, ketepatan waktu laporan, dan kualitas rekomendasi yang diberikan oleh SPI
- (5) Kriteria evaluasi kerja SPI didasarkan pada pencapaian Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) serta tingkat tindak lanjut unit kerja atas temuan audit
- (6) Pemberhentian anggota sebelum masa jabatan berakhir dapat dilakukan apabila anggota melakukan pelanggaran kode etik, membocorkan rahasia perusahaan, atau tidak lagi memenuhi kualifikasi yang ditetapkan
- (7) Mekanisme pemberhentian resmi dilakukan melalui penerbitan Surat Keputusan Direktur dengan mencantumkan alasan yang sesuai dengan ketentuan internal

- (8) Independensi pasca tugas memastikan bahwa mantan anggota SPI dapat kembali ke unit kerja asal atau mutasi ke unit lain tanpa adanya diskriminasi akibat hasil audit yang pernah dilakukan

Pasal 23
Uraian Tugas SPI

- (1) Penyusunan rencana audit tahunan yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan fokus pada area yang memiliki risiko tinggi
- (2) Pemeriksaan kepatuhan operasional untuk memastikan seluruh unit kerja menjalankan aktivitas sesuai dengan standar prosedur operasional dan peraturan yang berlaku
- (3) Audit keuangan dan aset secara berkala guna memastikan penggunaan anggaran yang efisien serta perlindungan terhadap aset rumah sakit dari potensi penyimpangan
- (4) Evaluasi sistem pengendalian internal untuk menilai keandalan pelaporan keuangan dan efektivitas pengelolaan manajemen di seluruh lini organisasi
- (5) Penyampaian laporan hasil audit kepada Direktur secara objektif yang memuat temuan-temuan di lapangan beserta bukti pendukung yang akurat
- (6) Pemberian rekomendasi perbaikan yang bersifat konstruktif dan solutif terhadap kelemahan sistem yang ditemukan selama proses pengawasan
- (7) Pemantauan tindak lanjut hasil audit guna memastikan bahwa setiap unit kerja telah mengimplementasikan saran perbaikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan
- (8) Pelaksanaan audit investigasi apabila ditemukan indikasi penyimpangan atau kecurangan (fraud) yang berpotensi merugikan rumah sakit
- (9) Pemberian jasa konsultasi internal bagi unit kerja dalam rangka pengembangan sistem manajemen dan mitigasi risiko tanpa mengurangi independensi pengawas
- (10) Koordinasi laporan pengawasan berkala untuk disampaikan secara transparan kepada Direksi sebagai bahan pengambilan keputusan strategis

Pasal 24
Tanggung Jawab SPI

- (1) Penjaminan integritas laporan keuangan melalui pengawasan yang ketat terhadap sistem pembukuan dan penggunaan anggaran rumah sakit
- (2) Keamanan dan perlindungan aset dari berbagai bentuk pemborosan, penyalahgunaan, maupun kehilangan akibat lemahnya sistem kendali internal
- (3) Penyajian informasi hasil pengawasan yang objektif kepada Direktur untuk mendukung pengambilan keputusan yang akurat dan berbasis data
- (4) Peningkatan efektivitas tata kelola dengan memastikan seluruh lini organisasi berfungsi secara optimal sesuai dengan tujuan strategis perusahaan
- (5) Kepatuhan terhadap standar operasional dan hukum dengan memastikan tidak ada pelanggaran terhadap prosedur internal maupun regulasi pemerintah yang berlaku
- (6) Kerahasiaan data dan dokumen institusi yang diperoleh selama proses audit agar tidak disalahgunakan atau jatuh ke pihak yang tidak berwenang
- (7) Pengembangan sistem pengendalian internal yang dinamis dan mampu beradaptasi dengan perubahan serta risiko baru di industri perumahsakit
- (8) Kredibilitas fungsi pengawasan dengan menjunjung tinggi kode etik audit internal dan profesionalisme dalam setiap tindakan pemeriksaan

Pasal 25
Wewenang SPI

- (1) Akses tanpa batas terhadap dokumen dan data meliputi seluruh catatan, buku administrasi, dokumen keuangan, hingga data elektronik di semua unit kerja rumah sakit
- (2) Pemeriksaan terhadap aset fisik guna memastikan keberadaan dan kondisi aset milik rumah sakit di seluruh area operasional
- (3) Pemanggilan staf dan pejabat pengelola untuk meminta keterangan, penjelasan, atau konfirmasi terkait temuan audit maupun isu manajerial lainnya
- (4) Melakukan observasi lapangan secara langsung pada proses pelayanan maupun administrasi guna memvalidasi kepatuhan terhadap standar operasional prosedur
- (5) Meminta bukti-bukti pendukung asli dari setiap transaksi atau kegiatan yang sedang dalam proses pemeriksaan atau audit
- (6) Memberikan saran dan rekomendasi perbaikan yang bersifat mengikat bagi unit kerja untuk ditindaklanjuti sesuai dengan arahan Direktur
- (7) Menjalankan audit investigatif khusus atas perintah Direktur jika ditemukan indikasi penyimpangan yang bersifat krusial atau merugikan institusi
- (8) Melibatkan tenaga ahli eksternal dalam proses pengawasan tertentu dengan persetujuan Direktur apabila diperlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki tim internal

BAB VI DIREKSI RUMAH SAKIT

Pasal 26 Kualifikasi Direksi

- (1) Definisi Direksi Rumah Sakit mencakup seluruh pejabat struktural yang terdiri dari Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, hingga Satuan Pengawas Internal dengan nomenklatur yang disesuaikan pada kebutuhan institusi
- (2) Otoritas pengangkatan dan pemberhentian Direktur Rumah Sakit berada sepenuhnya di bawah kewenangan Direktur PT
- (3) Pertanggungjawaban operasional dilakukan oleh Direktur secara langsung kepada Direktur PT atas seluruh aktivitas rumah sakit
- (4) Evaluasi komposisi organisasi dapat dilakukan melalui analisis kebutuhan guna melakukan perubahan jumlah maupun jenis jabatan Direksi demi memenuhi tuntutan perubahan institusi
- (5) Mekanisme perubahan struktur dilaksanakan dengan mengusulkan hasil analisis organisasi kepada Direktur Utama untuk mendapatkan persetujuan
- (6) Penetapan perubahan komposisi Direksi Rumah Sakit secara resmi ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur PT

Pasal 27 Pengangkatan, Penilaian dan Pemberhentian

- (1) Pengangkatan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur berdasarkan pemenuhan standar kualifikasi pendidikan, pengalaman klinis/manajerial, dan sertifikasi pelatihan kepemimpinan yang dipersyaratkan.
- (2) Pengangkatan dilakukan melalui mekanisme seleksi internal atau penunjukan langsung dengan mempertimbangkan rekam jejak, kredibilitas, dan integritas calon pejabat.
- (3) Penilaian prestasi kerja dilakukan secara berkala oleh Direktur berdasarkan pencapaian target program kerja, efisiensi penggunaan sumber daya, dan kualitas koordinasi antarunit.

- (4) Penilaian mencakup aspek kedisiplinan, kemampuan kepemimpinan, kepatuhan terhadap standar prosedur operasional, serta hasil sistem pengendalian internal di masing-masing bidang.
- (5) Pemberhentian dapat terjadi karena masa jabatan berakhir, mencapai batas usia pensiun, atau atas permintaan sendiri (mengundurkan diri) secara tertulis kepada Direktur.
- (6) Pemberhentian dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Direktur apabila pejabat yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat, etika, atau tidak mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
- (7) Pemberhentian dilakukan jika pejabat dinyatakan tidak mampu secara fisik atau mental untuk menjalankan tugas berdasarkan surat keterangan medis yang sah.

Pasal 28
Kualifikasi Direksi

- (1) Kepala Bidang Pelayanan Medis
 - a. Pendidikan
 - Dokter Umum/ Gigi/ Spesialis
 - S1 Kesehatan/Profesi Perawat
 - Memiliki STR dan SIP yang masih berlaku (untuk dokter)
 - b. Pengetahuan dan Keterampilan
 - Memiliki keterampilan dalam perencanaan, penggerak dan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.
 - Mempunyai kemampuan menangani yang berhubungan dengan penanganan pasien.
 - c. Pengalaman
 - Mempunyai pengalaman di bidang kesehatan minimal 2 tahun.
- (2) Kepala Bidang Penunjang Medis
 - a. Pendidikan
 - Dokter Umum/ Gigi/ Spesialis
 - S1 Kesehatan / Profesi Ners
 - Memiliki STR dan SIP yang masih berlaku (untuk dokter/nakes)
 - b. Pengetahuan dan Keterampilan
 - Memiliki keterampilan dalam perencanaan, penggerak dan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.
 - Mempunyai kemampuan menangani yang berhubungan dengan penanganan pasien.
 - c. Pengalaman
 - Mempunyai pengalaman di bidang kesehatan minimal 2 tahun.
- (3) Kepala Bagian Umum
 - a. Pendidikan
 - Minimal SMA/SMK atau sedang dalam proses pendidikan menempuh S1
 - b. Pengetahuan dan Keterampilan
 - Memiliki keterampilan dalam perencanaan, penggerak dan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.
 - c. Pengalaman
 - Mempunyai pengalaman di Rumah Sakit minimal 2 tahun.

Pasal 29
Uraian Tugas Direksi

- (1) Melaksanakan fungsi perencanaan
 - a. Menyusun rencana kerja, program dan anggaran di bidang masing masing terkait SDM, fasilitas, pengembangan pelayanan, Pendidikan dan Pelatihan Staf, Mutu, keselamatan pasien dan keselamatan kerja staf.

- b. Menyusun perencanaan kebutuhan staf berdasarkan pola ketenagaan dan pengembangan pelayanan
 - c. Menyusun program orientasi bagi staf penunjang medis yang baru yang akan bekerja di rumah sakit.
 - d. Menyusun standar, protap, SPO berkolaborasi dengan seluruh tim/staf bagian
 - e. Melakukan rapat dan pertemuan secara berkala
 - f. Melaksanakan rekrutmen staf dan menyeleksi serta membantu mengadakan pengadaan perjanjian dengan staf penunjang medik dan bekerjasama dengan SDM.
- (2) Melaksanakan fungsi pergerakan
- a. Mengatur dan mengkondisikan seluruh kegiatan kolaborasi dengan kepala bidang lain dan kepala unit lain.
 - b. Membimbing staf untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar.
 - c. Memberikan laporan dan evaluasi yang dilakukan di penunjang medis
 - d. Melaksanakan pengaturan penempatan dan penempatan kembali staf berdasarkan kompetensi, kebutuhan atau kekurangan staf dan pertimbangan nilai – nilai, kepercayaan dan agama staf.
 - e. Ikut serta dalam pengembangan dan pemasaran rumah sakit.
- (3) Melaksanakan fungsi pengawasan, pengendalian, dan penilaian
- a. Mengendalikan dan menilai pelaksanaan yang telah ditentukan.
 - b. Melakukan penilaian kinerja dan mutu kepala unit yang berada dibawah tanggung jawabnya.
 - c. Melakukan supervisi staf terkait dengan kewenangan klinisnya.
 - d. Melakukan evaluasi perencanaan kebutuhan staf berdasarkan kebutuhan.

Pasal 30

Tanggung Jawab Direksi

- (1) Kebenaran dan ketepatan perencanaan kebutuhan staf di unitnya.
- (2) Kebenaran dan ketepatan pengembangan pelayanan di unitnya.
- (3) Kebenaran dan ketepatan semua system administrasi manajemen yang berada dibawah tanggung jawabnya.
- (4) Menjamin kelancaran pelayanan mulai dari SDM, sarana dan prasarana baik medis ataupun nonmedis
- (5) Tercapainya pelayanan medis yang professional dan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas efektif dan efisien

Pasal 31

Wewenang Direksi

- (1) Mengakses terhadap semua dokumen, pencatatan, personal dan fisik, informasi untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
- (2) Memberikan pengarahan, teguran, nasehat/pendapat kepada bawahannya dalam pelaksanaan tugasnya.
- (3) Mengawasi pelaksanaan kegiatan, menganalisa dan mengevaluasi yang ditetapkan di rumah sakit untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pasien.
- (4) Mengawasi, mengendalikan dan menilai pendayagunaan staf, peralatan dan mutu.
- (5) Mengusulkan kerja sama dengan pihak ketiga yang berkaitan dengan kelancaran operasional di bagiannya.
- (6) Menandatangani surat dan dokumen yang menjadi wewenang kepala bidang penunjang medis

- (7) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, khususnya yang diberikan dengan pelayanan
- (8) Mengikuti rapat koordinasi berkala yang diadakan oleh Rumah Sakit. maupun PT Disa Prima Medika.
- (9) Menerima tanggung jawab yang didelegasikan oleh Direktur.

Pasal 32 Rapat Direksi

- (1) Menyelenggarakan rapat pemilik dengan direksi sekurang-kurangnya 1 bulan sekali
- (2) Menyelenggarakan rapat Direksi sekurang-kurangnya 1 minggu sekali
- (3) Menyelenggarakan rapat kepala bidang dengan kepala instalasi atau unit sekurang-kurangnya 1 minggu sekali
- (4) Membahas hal-hal yang berhubungan dengan rumah sakit sesuai tugas kewenangan dan kewajibannya dalam rapat pemilik
- (5) Mengambil keputusan rapat Direksi berdasarkan musyawarah mufakat
- (6) Melakukan konsultasi dengan representasi pemilik jika keputusan rapat Direksi tidak mencapai mufakat
- (7) Melaksanakan rapat kinerja tahunan antara pemilik dengan Direksi Rumah Sakit sekurang-kurangnya 1 tahun sekali
- (8) Mewajibkan pembuatan undangan notulen dan daftar hadir untuk setiap rapat yang diselenggarakan

BAB VII KOMITE DAN TIM

Pasal 33 Pembentukan Komite dan Tim

- (1) Direksi wajib membentuk komite sebagai wadah profesional dengan otoritas dalam organisasi tenaga medis keperawatan etik hukum serta pengembangan teknologi kesehatan
- (2) Seluruh komite dan tim merupakan badan non-struktural yang berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada Direktur
- (3) Pembentukan komite dan tim bertujuan mengawal mutu pelayanan kesehatan berbasis keselamatan pasien dan pencegahan infeksi
- (4) Daftar Komite Rumah Sakit
 - a. Komite Medis
 - b. Komite Keperawatan
 - c. Komite Tenaga Kesehatan Lain
 - d. Komite Mutu dan Keselamatan Pasien
 - e. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)
 - f. Komite Farmasi dan Terapi
 - g. Komite Etik
 - h. Komite K3RS (Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit)
 - i. Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA)
- (5) Daftar Tim Khusus Rumah Sakit
 - a. Tim Review Rekam Medis
 - b. Tim PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif)
 - c. Tim TB DOTS
 - d. Tim HIV
 - e. Tim Geriatri
 - f. Tim KB (Keluarga Berencana)

- g. Tim Stunting
- h. Tim HTA (*Health Technology Assessment*)

KOMITE MEDIS

Pasal 34 Organisasi Komite Medis

- (1) Komite Medis adalah wadah profesional medis yang keanggotaannya berasal dari ketua kelompok tenaga medis atau yang mewakili
- (2) Komite Medis memiliki otoritas tertinggi dalam pengorganisasian tenaga medis dan berada langsung di bawah Direktur Rumah Sakit
- (3) Susunan organisasi Komite Medis terdiri dari Ketua Wakil ketua Sekretaris dan Anggota
- (4) Pembentukan Komite Medis bertujuan menyelenggarakan tata kelola klinis yang baik demi menjamin mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien
- (5) Komite Medis merupakan organisasi non struktural dan bukan merupakan wadah perwakilan dari tenaga medis
- (6) Pembentukan Komite Medis ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit
- (7) Direktur Rumah Sakit memiliki wewenang untuk menunjuk Ketua Komite Medis pada saat pembentukan untuk pertama kalinya

Pasal 35 Kualifikasi Komite Medis

- (1) Ketua Komite Medis
 - a. Dijabat oleh dokter purna waktu atau paruh waktu yang dipilih secara demokratis oleh para ketua kelompok tenaga medis
 - b. Diangkat secara resmi melalui Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit
 - c. Memiliki wewenang untuk memilih Sekretaris Komite Medis
 - d. Diperbolehkan merangkap jabatan sebagai salah satu Ketua Sub Komite
 - e. Memiliki kredibilitas yang tinggi serta integritas keilmuan dan etika profesi yang kuat
 - f. Memiliki wawasan luas mengenai ilmu profesi serta peka terhadap perkembangan perumahsakitan
 - g. Memiliki kepribadian yang jujur bijaksana terbuka serta disegani di lingkungan profesinya
- (2) Sekretaris Komite Medis
 - a. Dipilih langsung oleh Ketua Komite Medis untuk membantu kelancaran organisasi
 - b. Bisa dipilih dari salah satu anggota Komite Medis jika jumlah dokter di rumah sakit terbatas
 - c. Diperbolehkan menjabat sebagai ketua salah satu Sub Komite
 - d. Dibantu oleh tenaga administrasi atau staf sekretariat dalam menjalankan tugas kesehariannya
 - e. Keanggotaan Komite Medis
- (3) Jumlah anggota Komite Medis bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan jumlah total tenaga medis yang ada di rumah sakit

Pasal 36
Pengangkatan, Penilaian dan Pemberhentian

- (1) Pengangkatan Ketua Komite Medis ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur berdasarkan hasil pemilihan secara demokratis oleh para Ketua Kelompok Tenaga medis (KSM).
- (2) Pengangkatan anggota Komite Medis dan ketua-ketua Sub Komite (Kredensial, Mutu Profesi, Etika & Disiplin) dilakukan oleh Direktur atas usulan Ketua Komite Medis.
- (3) Masa jabatan personil Komite Medis ditetapkan dalam jangka waktu tertentu (biasanya 3 tahun) dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya sesuai ketentuan Medical Staff Bylaws.
- (4) Penilaian kinerja Komite Medis dilakukan secara periodik oleh Direktur untuk mengevaluasi efektivitas tata kelola klinis, pelaksanaan audit medis, dan proses kredensial staf.
- (5) Indikator penilaian mencakup ketepatan waktu pemberian rekomendasi kewenangan klinis, keberhasilan pembinaan etika staf, serta kontribusi dalam peningkatan mutu pelayanan medis.
- (6) Pemberhentian anggota atau pengurus Komite Medis terjadi apabila masa jabatan berakhir, mengundurkan diri, atau tidak lagi terdaftar sebagai tenaga medis di rumah sakit tersebut.
- (7) Pemberhentian dapat dilakukan oleh Direktur sebelum masa jabatan berakhir jika personil terlibat tindak pidana, melanggar etika profesi berat, atau tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.
- (8) Pemberhentian dilakukan jika personil mengalami kendala kesehatan fisik atau mental yang menghalangi pelaksanaan tugas profesi dan organisasi secara permanen.

Pasal 37
Uraian Tugas Komite Medis

- (1) Tugas Pokok Komite Medis
 - a. Membantu Direktur Rumah Sakit menyusun standar pelayanan medis dan memantau pelaksanaannya
 - b. Melaksanakan pembinaan etika profesi disiplin dan mutu profesi tenaga medis
 - c. Mengatur pembagian kewenangan profesi antar kelompok tenaga medis
 - d. Membantu Direktur Rumah Sakit menyusun serta memantau pelaksanaan Medical Staff Bylaws
 - e. Menyusun kebijakan dan prosedur yang terkait dengan aspek medis-legal serta etik-legal
 - f. Melakukan proses kredensial bagi seluruh tenaga medis yang akan memberikan pelayanan di Rumah Sakit
 - g. Berkoordinasi dengan Bidang Pelayanan dalam pembinaan pelaksanaan tugas kelompok tenaga medis
 - h. Meningkatkan program pelayanan pendidikan pelatihan serta penelitian dan pengembangan bidang medis
 - i. Melakukan monitoring dan evaluasi mutu pelayanan medis melalui audit medis dan tinjauan kasus klinis
 - j. Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Direktur Rumah Sakit
- (2) Fungsi Kredensial (Menjamin Kompetensi)
 - a. Menyusun dan mengompilasi daftar kewenangan klinis berdasarkan norma keprofesian

- b. Menyelenggarakan pemeriksaan kompetensi kesehatan fisik dan mental perilaku serta etika profesi
 - c. Mengevaluasi data pendidikan profesional kedokteran berkelanjutan tenaga medis
 - d. Melaksanakan wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis
 - e. Menilai dan memutuskan pemberian kewenangan klinis bagi tenaga medis
 - f. Melakukan proses rekredensial secara berkala sesuai masa berlaku surat penugasan klinis
 - g. Memberikan rekomendasi kewenangan klinis sebagai dasar penerbitan surat penugasan klinis oleh Direktur
- (3) Fungsi Mutu Profesi (Memelihara Kualitas)
- a. Menyelenggarakan pelaksanaan audit medis secara rutin dan terencana
 - b. Memberikan rekomendasi pertemuan ilmiah internal untuk pendidikan berkelanjutan tenaga medis
 - c. Memberikan rekomendasi kegiatan ilmiah eksternal bagi tenaga medis rumah sakit
 - d. Memberikan rekomendasi proses pendampingan (proctoring) bagi tenaga medis yang membutuhkan
- (4) Fungsi Etika dan Disiplin (Menjaga Perilaku)
- a. Melaksanakan pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran di lingkungan rumah sakit
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap tenaga medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin
 - c. Memberikan rekomendasi tindakan pendisiplinan atas perilaku profesional tenaga medis
 - d. Memberikan nasehat dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis pada asuhan medis pasien

Pasal 38

Tanggung Jawab Komite Medis

- (1) Mendukung komunikasi yang efektif antar tenaga profesional;
- (2) Menyusun kebijakan, pedoman, prosedur serta protokol, tata hubungan kerja, alur klinis, dan dokumen lain yang mengatur layanan klinis;
- (3) Menyusun kode etik profesi; dan
- (4) Memantau mutu pelayanan pasien lainnya
- (5) Bertanggung jawab atas terselenggaranya tata kelola klinis (clinical governance) yang baik di rumah sakit
- (6) Menjamin bahwa setiap tenaga medis yang memberikan pelayanan memiliki kompetensi dan kewenangan klinis yang sesuai (kredensial)
- (7) Menjaga mutu profesi tenaga medis agar pelayanan yang diberikan selalu sesuai dengan standar profesi dan ilmu pengetahuan terkini
- (8) Memastikan penegakan etika disiplin dan perilaku profesional tenaga medis di lingkungan rumah sakit
- (9) Menjamin terlaksananya audit medis dan evaluasi kinerja klinis secara berkala demi keselamatan pasien
- (10) Memberikan rekomendasi objektif kepada Direktur terkait pengangkatan kembali atau pencabutan kewenangan klinis tenaga medis
- (11) Melindungi pasien dari pelayanan medis yang tidak kompeten melalui sistem monitoring morbiditas dan mortalitas
- (12) Memastikan seluruh tenaga medis mematuhi Medical Staff Bylaws serta peraturan perundang-undangan yang berlaku

- (13) Bertanggung jawab langsung kepada Direktur Rumah Sakit atas seluruh laporan kegiatan dan evaluasi mutu medis

Pasal 39
Wewenang Komite Medis

- (1) Memberikan rekomendasi rincian kewenangan klinis (*delineation of clinical privilege*) bagi setiap tenaga medis
- (2) Memberikan rekomendasi penerbitan surat penugasan klinis (clinical appointment) kepada Direktur
- (3) Memberikan rekomendasi penolakan kewenangan klinis tertentu apabila tenaga medis dianggap tidak memenuhi syarat
- (4) Memberikan rekomendasi perubahan atau modifikasi rincian kewenangan klinis berdasarkan hasil evaluasi kompetensi
- (5) Memberikan rekomendasi tindak lanjut hasil audit medis untuk perbaikan kualitas pelayanan
- (6) Memberikan rekomendasi pelaksanaan pendidikan kedokteran berkelanjutan bagi tenaga medis
- (7) Memberikan rekomendasi pendampingan (proctoring) bagi tenaga medis yang memerlukan supervisi dalam tindakan klinis
- (8) Memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin profesi terhadap tenaga medis yang melakukan pelanggaran

Pasal 40
Rapat Komite Medis

- (1) Menyelenggarakan rapat rutin internal Komite Medis sekurang-kurangnya 1 kali dalam sebulan.
- (2) Menyelenggarakan rapat Komite Medis bersama seluruh Kelompok Tenaga medis (KSM) atau tenaga dokter minimal 1 kali dalam sebulan.
- (3) Menyelenggarakan rapat koordinasi antara Komite Medis dengan Direktur Rumah Sakit atau Kepala Bidang Pelayanan minimal 1 kali dalam sebulan.
- (4) Menyelenggarakan rapat darurat sewaktu-waktu sesuai kebutuhan untuk membahas masalah yang bersifat mendesak.
- (5) Menetapkan tugas, kewajiban, serta mekanisme pertanggungjawaban sub-komite terhadap program kerja yang dijalankan.
- (6) Rapat Kelompok Tenaga medis dan atau Komite Medis dapat dilaksanakan apabila kuorum tercapai.
- (7) Kuorum di anggap tercapai apabila dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Kelompok Tenaga medis.
- (8) Dalam hal Kuorum tidak tercapai dalam waktu 1 (satu) jam dalam waktu rapat yang telah ditentukan maka rapat dapat di tangguhkan untuk dilanjutkan pada suatu tempat, waktu dan hari yang lain.
- (9) Dalam hal kuorum juga tidak tercapai dalam waktu 1 (satu) jam dan waktu yang telah ditentukan pada waktu berikutnya, maka rapat di lanjutkan dan segala keputusan yang ada dalam risalah rapat di sahkan dalam anggota Kelompok Tenaga medis dan atau Komite Medis berikutnya.
- (10) Direktur dapat mengusulkan perubahan atau pembatalan setiap keputusan yang diambil pada rapat rutin atau rapat khusus sebelumnya dengan syarat usul perubahan atau pembatalan tersebut di cantumkan dalam pemberitahuan atau undangan rapat sebagaimana ditentukan dalam peraturan ini.

- (11) Dalam hal khusus perubahan atau pembatalan keputusan Direktur Rumah Sakit tidak diterima dalam rapat tersebut maka usulan tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam kurun waktu 3 (bulan) terhitung sejak saat ditolaknya usulan tersebut.

Pasal 41
Sub Komite Medis

- (1) Sub Komite Kredensial;
- (2) Sub Komite Mutu Profesi Medis;
- (3) Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi.

Pasal 42
Tata Kerja Sub Komite Kredensial

- (1) Tenaga medis mengajukan permohonan Kewenangan Klinis kepada Direktur dengan mengisi formulir daftar rincian Kewenangan Klinis yang telah disediakan rumah sakit dengan dilengkapi bahan-bahan pendukung;
- (2) Berkas permohonan tenaga medis yang telah lengkap disampaikan oleh Direktur kepada Komite Medis;
- (3) Kajian terhadap formulir daftar rincian Kewenangan Klinis yang telah diisi oleh pemohon;
- (4) Pengkajian oleh Subkomite Kredensial meliputi elemen kompetensi, psikomotor, kompetensi fisik, kompetensi mental/perilaku; dan perilaku etis.
- (5) Kewenangan Klinis yang diberikan mencakup derajat kompetensi dan cakupan praktik;
- (6) Daftar rincian Kewenangan Klinis diperoleh dengan cara:
 - a. Menyusun daftar Kewenangan Klinis dilakukan dengan meminta masukan dari setiap Kelompok Tenaga medis;
 - b. Mengkaji Kewenangan Klinis bagi pemohon dengan menggunakan daftar rincian Kewenangan Klinis; dan
 - c. Mengkaji ulang daftar rincian Kewenangan Klinis bagi tenaga medis dilakukan secara periodik;
- (7) Rekomendasi pemberian Kewenangan Klinis dilakukan oleh Komite Medis berdasarkan masukan dari Sub Komite Kredensial;
- (8) Sub Komite Kredensial melakukan rekredensial bagi setiap tenaga medis yang mengajukan permohonan pada saat berakhirnya masa berlaku Surat Penugasan Klinis (SPK) dengan rekomendasi berupa:
 - a. Kewenangan klinis yang bersangkutan dilanjutkan;
 - b. Kewenangan klinis yang bersangkutan ditambah;
 - c. Kewenangan klinis yang bersangkutan dikurangi;
 - d. Kewenangan klinis yang bersangkutan dibekukan untuk waktu tertentu; kewenangan klinis yang bersangkutan diubah/ dimodifikasi; dan
 - e. Kewenangan klinis yang bersangkutan diakhiri;
- (9) Bagi tenaga medis yang ingin memulihkan Kewenangan Klinis yang dikurangi atau menambah Kewenangan Klinis yang dimiliki dapat mengajukan permohonan kepada Komite Medis melalui Direktur. Selanjutnya, Komite Medis menyelenggarakan pembinaan profesi antara lain melalui mekanisme pendampingan (proctoring).

Pasal 43
Tata Kerja Sub Komite Mutu Profesi

- (1) Pelaksanaan audit medis harus dapat memenuhi 4 (empat) peran penting yaitu:

- a. Sebagai sarana untuk melakukan penilaian terhadap kompetensi masing-masing tenaga medis pemberi pelayanan di rumah sakit;
 - b. Sebagai dasar untuk pemberian Kewenangan Klinis/ Clinical Privilege sesuai kompetensi yang dimiliki;
 - c. Sebagai dasar bagi Komite Medis dalam merekomendasikan pencabutan atau penangguhan Kewenangan Klinis/ Clinical Privilege:
 - a. Sebagai dasar bagi Komite Medis dalam merekomendasikan perubahan/modifikasi rincian Kewenangan Klinis seorang tenaga medis.
- (2) Langkah-langkah pelaksanaan audit medis:
- a. Pemilihan topik yang akan dilakukan audit;
 - b. Penetapan standar dan kriteria, penetapan jumlah kasus,/ sampel yang akan diaudit;
 - c. Membandingkan standar/ kriteria dengan pelaksanaan pelayanan;
 - d. Melakukan analisis kasus yang tidak sesuai standar dan kriteria;
 - b. Menerapkan perbaikan;
 - a. Rencana reaudit.
- (3) Subkomite Mutu Profesi dapat merekomendasikan pendidikan berkelanjutan bagi tenaga medis:
- a. Menentukan pertemuan ilmiah yang harus dilaksanakan oleh masing-masing kelompok tenaga medis dengan pengaturan waktu yang disesuaikan;
 - b. Pertemuan tersebut dapat pula berupa pembahasan kasus antara lain meliputi kasus kematian (death case), kasus sulit maupun kasus langka;
 - c. Setiap kali pertemuan ilmiah harus disertai notulensi, kesimpulan dan daftar hadir peserta yang akan dijadikan pertimbangan dalam penilaian disiplin profesi;
 - d. Notulensi beserta daftar hadir menjadi dokumen/ arsip Sub Komite Mutu Profesi;
 - e. Sub Komite Mutu Profesi bersama-sama dengan kelompok tenaga medis menentukan kegiatan ilmiah yang akan dibuat oleh Sub Komite Mutu Profesi yang melibatkan tenaga medis Rumah Sakit sebagai narasumber dan peserta aktif;
 - f. Setiap kelompok tenaga medis wajib menentukan minimal satu kegiatan ilmiah yang akan dilaksanakan dengan Sub Komite Mutu Profesi pertahun;
 - g. Sub Komite Mutu Profesi bersama dengan bagian pendidikan dan penelitian Rumah Sakit memfasilitasi kegiatan tersebut dan dengan mengusahakan satuan angka kredit dari ikatan profesi;
 - h. Menentukan kegiatan ilmiah yang dapat diikuti oleh masing-masing tenaga medis setiap tahun dan tidak mengurangi hari cuti tahunannya;
 - i. Memberikan persetujuan terhadap permintaan tenaga medis sebagai asupan kepada Manajemen.
- (4) Sub Komite Mutu Profesi dapat memfasilitasi proses pendampingan (proctoring) bagi tenaga medis yang membutuhkan:
- a. Menentukan nama tenaga medis yang akan mendampingi tenaga medis yang sedang mengalami sanksi disiplin/ mendapatkan pengurangan Kewenangan Klinis;
 - b. Komite medis berkoordinasi dengan Direktur untuk memfasilitasi semua sumber daya yang dibutuhkan untuk proses pendampingan (proctoring) tersebut.

Pasal 44

Tata Kerja Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi memiliki semangat yang berlandaskan:
- a. Peraturan internal rumah sakit;

- b. Peraturan internal tenaga medis;
 - c. Etika rumah sakit;
 - d. Norma etika medis dan norma-norma bioetika.
- (2) Tolak ukur dalam upaya pendisiplinan perilaku profesional tenaga medis yaitu:
- a. Pedoman pelayanan kedokteran di rumah sakit;
 - b. Prosedur kinerja pelayanan di rumah sakit;
 - c. Daftar Kewenangan Klinis di rumah sakit;
 - d. Kode etik kedokteran Indonesia;
 - e. Pedoman perilaku profesional kedokteran/ buku penyelenggaraan praktik kedokteran yang baik;
 - f. Pedoman pelanggaran disiplin kedokteran yang berlaku di Indonesia;
 - g. Pedoman pelayanan medis/ klinik;
 - h. Standar prosedur operasional asuhan medis.
- (3) Penegakan disiplin profesi dilakukan oleh sebuah panel yang dibentuk oleh Ketua Sub Komite Etika dan Disiplin profesi. Panel terdiri dari 3 orang tenaga medis atau lebih dalam jumlah ganjil dengan susunan sebagai berikut:
- a. 1 (satu) orang dari Sub Komite Etika dan Disiplin profesi yang memiliki disiplin ilmu yang berbeda dari yang diperiksa;
 - b. 2 (dua) orang atau lebih tenaga medis dari disiplin ilmu yang sama dengan yang diperiksa dapat berasal dari dalam rumah sakit atau luar rumah sakit, baik atas permintaan Komite Medis dengan persetujuan Direktur.
- (4) Dasar dugaan pelanggaran disiplin profesi menyangkut hal-hal antara lain:
- a. Kompetensi klinis;
 - 1) Penatalaksanaan kasus medis;
 - 2) Pelanggaran disiplin profesi;
 - 3) Penggunaan obat dan alat kesehatan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan kedokteran di rumah sakit;
 - 4) Ketidakmampuan bekerja sama dengan staf rumah sakit yang dapat membahayakan pasien;
 - b. Pemeriksaan:
 - 1) Dilakukan oleh panel pendisiplinan profesi;
 - 2) Melalui proses pembuktian;
 - 3) Dicatat oleh petugas sekretariat Komite Medis;
 - 4) Terlapor dapat didampingi oleh personil dari rumah sakit tersebut;
 - 5) Panel dapat menggunakan keterangan ahli sesuai kebutuhan;
 - 6) Seluruh pemeriksaan yang dilakukan oleh panel disiplin profesi bersifat tertutup dan pengambilan keputusannya bersifat rahasia.
 - c. Keputusan
Keputusan panel yang dibentuk oleh Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi diambil berdasarkan suara terbanyak, untuk menentukan ada atau tidak pelanggaran disiplin profesi kedokteran di rumah sakit. Bilamana terlapor merasa keberatan dengan keputusan panel, maka yang bersangkutan dapat mengajukan keberatannya dengan memperbarui kepada Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi yang kemudian akan membentuk panel baru. Keputusan ini bersifat final dan dilaporkan kepada Direktur.
 - d. Rekomendasi pemberian tindakan pendisiplinan profesi pada tenaga medis oleh Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi di Rumah Sakit berupa:
 - 1) Peringatan tertulis;
 - 2) Limitasi (reduksi) Kewenangan Klinis;
 - 3) Bekerja dibawah supervisi dalam waktu tertentu oleh orang yang mempunyai kewenangan untuk pelayanan medis tersebut;
 - 4) Pencabutan Kewenangan Klinis sementara atau selamanya.

- e. Pelaksanaan Keputusan
Keputusan Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi tentang pemberian tindakan disiplin profesi diserahkan kepada Direktur oleh Ketua Komite Medis sebagai rekomendasi, selanjutnya Direktur melakukan eksekusi.
- (5) Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi menyusun materi kegiatan pembinaan profesionalisme kedokteran. Pelaksanaan pembinaan profesionalisme kedokteran dapat diselenggarakan dalam bentuk ceramah, diskusi, simposium, lokakarya yang dilakukan oleh unit kerja rumah sakit seperti unit pendidikan dan penelitian atau Komite Medis.
- (6) Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi mengadakan pertemuan pembahasan kasus dengan mengikutsertakan pihak-pihak terkait yang kompeten untuk memberikan pertimbangan pengambilan keputusan etis.

KOMITE KEPERAWATAN

Pasal 45

Organisasi Komite Keperawatan

- (1) Pembentukan Komite Keperawatan bertujuan mewujudkan tata kelola klinis yang baik di Rumah Sakit
- (2) Komite Keperawatan merupakan organisasi non-struktural yang berada di bawah Direktur
- (3) Komite Keperawatan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur
- (4) Komite Keperawatan bukan merupakan wadah perwakilan atau serikat bagi staf keperawatan
- (5) Struktur organisasi Komite Keperawatan ditetapkan oleh Direktur
- (6) Susunan organisasi terdiri dari Ketua Komite Keperawatan
- (7) Susunan organisasi dilengkapi dengan Sekretaris Komite Keperawatan
- (8) Operasional teknis dilaksanakan oleh unit-unit Sub Komite
- (9) Sub Komite Kredensial bertugas melakukan proses verifikasi kompetensi seluruh staf keperawatan
- (10) Sub Komite Mutu Profesi bertugas menjaga dan meningkatkan standar kualitas kerja perawat
- (11) Sub Komite Etik Profesi bertugas melakukan pembinaan serta pengawasan disiplin profesi

Pasal 46

Pengangkatan, Penilaian dan Pemberhentian

- (1) Anggota Komite Keperawatan diangkat dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur
- (2) Masa bakti keanggotaan biasanya ditetapkan untuk jangka waktu tiga tahun
- (3) Ketua Komite Keperawatan dipilih dari staf keperawatan fungsional yang memenuhi kualifikasi
- (4) Penetapan personel harus mempertimbangkan representasi dari berbagai unit pelayanan
- (5) Penilaian kinerja Komite Keperawatan dilakukan secara berkala oleh Direktur
- (6) Parameter penilaian meliputi pencapaian program kerja dan efektivitas pembinaan profesi
- (7) Anggota dapat diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir jika mengundurkan diri
- (8) Pemberhentian dilakukan apabila anggota tidak lagi memenuhi syarat sebagai staf klinis
- (9) Personel dapat diberhentikan jika melakukan pelanggaran disiplin atau etika berat

- (10) Pemberhentian dapat terjadi jika anggota tidak dapat menjalankan tugas karena alasan kesehatan
- (11) Penggantian antar waktu dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan

Pasal 47

Kualifikasi Komite Keperawatan

- (1) Memiliki surat izin praktik yang sah dan masih berlaku
- (2) Memiliki pengalaman klinis yang mumpuni di bidang keperawatan atau kebidanan
- (3) Memiliki integritas tinggi serta perilaku profesional yang baik
- (4) Tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin atau etik berat
- (5) Memiliki kemauan dan kemampuan bekerja dalam tim
- (6) Memiliki sertifikasi atau pelatihan khusus sesuai bidang sub komite terkait
- (7) Memiliki kemampuan kepemimpinan dan manajerial bagi ketua komite
- (8) Bersedia meluangkan waktu di sela tugas klinis untuk menjalankan fungsi komite
- (9) Memahami regulasi rumah sakit dan standar akreditasi yang berlaku
- (10) Sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas organisasi

Pasal 48

Uraian Tugas Komite Keperawatan

- (1) Membantu Direktur dalam melaksanakan proses kredensial tenaga keperawatan
- (2) Melakukan pembinaan disiplin dan etika profesi bagi perawat dan bidan
- (3) Menyelenggarakan pengembangan profesi berkelanjutan bagi staf keperawatan
- (4) Menyelenggarakan layanan konsultasi terkait praktik keperawatan
- (5) Memfasilitasi forum tukar pendapat mengenai kebijakan dan pelaksanaan pelayanan
- (6) Memberikan motivasi dalam pemecahan masalah profesi melalui proses pembelajaran
- (7) Menggali inovasi dan ide kreatif untuk perbaikan kualitas profesi keperawatan
- (8) Menyelenggarakan program pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi
- (9) Melakukan advokasi dengan memberikan perlindungan terhadap hak-hak profesi
- (10) Memberikan dukungan dan bantuan terkait permasalahan hukum yang dihadapi staf keperawatan

Pasal 49

Tanggung Jawab Komite Keperawatan

- (1) Mendukung komunikasi yang efektif antar tenaga profesional;
- (2) Menyusun kebijakan, pedoman, prosedur serta protokol, tata hubungan kerja, alur klinis, dan dokumen lain yang mengatur layanan klinis;
- (3) Menyusun kode etik profesi; dan
- (4) Memantau mutu pelayanan pasien lainnya
- (5) Menjamin terselenggaranya pelayanan keperawatan yang aman bagi pasien
- (6) Menjamin seluruh staf keperawatan memiliki izin praktik yang sah
- (7) Menjamin kompetensi staf sesuai dengan kewenangan klinis yang diberikan
- (8) Menjaga mutu profesi melalui audit keperawatan dan pengembangan berkelanjutan
- (9) Menegakkan disiplin dan etika profesi di seluruh unit pelayanan
- (10) Melindungi masyarakat dari praktik keperawatan yang tidak kompeten

- (11) Melaporkan hasil evaluasi kinerja profesi secara berkala kepada Direktur
- (12) Memberikan rekomendasi penangguhan atau pencabutan kewenangan klinis jika diperlukan
- (13) Memberikan masukan kepada Direktur terkait kebijakan pelayanan keperawatan
- (14) Bertanggung jawab atas objektivitas proses kredensial bagi staf baru maupun lama

Pasal 50

Wewenang Komite Keperawatan

- (1) Memberikan rekomendasi pemberian atau penolakan kewenangan klinis staf keperawatan
- (2) Memberikan rekomendasi pemulihan kewenangan klinis bagi staf yang telah selesai masa pembinaan
- (3) Memberikan rekomendasi penangguhan kewenangan klinis jika ditemukan pelanggaran atau ketidakmampuan
- (4) Memberikan rekomendasi pencabutan kewenangan klinis secara permanen dalam kondisi tertentu
- (5) Memberikan rekomendasi tindak lanjut bagi staf keperawatan yang melakukan pelanggaran disiplin
- (6) Memberikan rekomendasi program pengembangan profesi bagi seluruh staf keperawatan
- (7) Memberikan rekomendasi hasil audit keperawatan untuk perbaikan mutu pelayanan
- (8) Melakukan klarifikasi dan investigasi terkait dugaan pelanggaran etik atau disiplin profesi
- (9) Mengusulkan pembentukan panel ahli atau panitia ad hoc untuk kasus klinis tertentu
- (10) Meminta data dan informasi klinis yang diperlukan dalam rangka proses kredensial atau audit

Pasal 51

Rapat Komite

- (1) Koordinasi dilakukan secara berkala antara Komite Keperawatan dan Bidang Keperawatan
- (2) Jenis rapat terdiri dari Rapat Kerja, Rapat Rutin, Rapat Pleno, dan Sidang Tahunan
- (3) Rapat Kerja dilaksanakan setahun sekali untuk menyusun rencana kerja tahunan
- (4) Rapat Kerja bersifat terbuka dan dipimpin oleh Ketua Komite atau Kepala Bidang Keperawatan
- (5) Rapat Rutin diselenggarakan setiap tiga bulan sekali untuk membahas masalah keperawatan terkini
- (6) Rapat Rutin diikuti oleh Bidang Keperawatan, Komite Keperawatan, dan seluruh Kepala Unit
- (7) Rapat Pleno diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan mendesak
- (8) Rapat Pleno dikhususkan untuk membahas persoalan etik dan disiplin staf keperawatan
- (9) Sidang Tahunan diselenggarakan satu kali dalam setahun sebagai forum tertinggi
- (10) Agenda Sidang Tahunan meliputi evaluasi kegiatan tahun lalu dan penetapan rencana kerja baru
- (11) Keputusan dalam Sidang Tahunan sah jika disetujui minimal oleh 2/3 peserta yang hadir

Pasal 52
Sub Komite

- (1) Sub Komite Kredensial;
- (2) Sub Komite Mutu Profesi;
- (3) Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi.

Pasal 53
Tata Kerja Sub Komite Kredensial

- (1) Menyusun daftar rincian kewenangan klinis bagi tenaga keperawatan
- (2) Menyusun buku putih (white paper) sebagai acuan kompetensi profesi
- (3) Menerima hasil verifikasi persyaratan administrasi kredensial
- (4) Merekomendasikan tahapan dan prosedur proses kredensial staf
- (5) Merekomendasikan pemulihan kewenangan klinis bagi setiap tenaga keperawatan
- (6) Melaksanakan proses kredensial ulang secara berkala setiap tiga tahun
- (7) Membuat laporan lengkap seluruh proses kredensial kepada Ketua Komite Keperawatan
- (8) Meneruskan laporan hasil kredensial kepada Direktur melalui Ketua Komite
- (9) Mengusulkan pembentukan tim ad hoc kepada Ketua Komite Keperawatan jika diperlukan
- (10) Melibatkan tim ad hoc dalam menjalankan fungsi penilaian kompetensi yang spesifik
- (11) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme kredensial dan rekredensial diatur lebih lanjut dalam kebijakan dan/atau peraturan internal rumah sakit yang berlaku

Pasal 54
Tata Kerja Sub Komite Mutu Profesi

- (1) Menyusun data dasar profil tenaga keperawatan sesuai dengan area praktik masing-masing
- (2) Merekomendasikan perencanaan pengembangan profesional berkelanjutan bagi tenaga keperawatan
- (3) Melakukan audit asuhan keperawatan secara berkala untuk menjamin kualitas pelayanan
- (4) Memfasilitasi proses pendampingan (proctoring) bagi tenaga keperawatan sesuai kebutuhan klinis
- (5) Mengusulkan pembentukan tim ad hoc kepada Ketua Komite Keperawatan jika diperlukan
- (6) Tim ad hoc yang diusulkan dapat bersifat insidental maupun permanen
- (7) Menjamin pemeliharaan kompetensi seluruh staf keperawatan di rumah sakit
- (8) Melaporkan hasil evaluasi mutu profesi secara rutin kepada Ketua Komite Keperawatan

Pasal 55
Tata Kerja Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi

- (1) Melakukan sosialisasi kode etik profesi kepada seluruh tenaga keperawatan
- (2) Melakukan pembinaan rutin terkait etik dan disiplin profesi tenaga keperawatan
- (3) Melaksanakan upaya penegakan disiplin profesi keperawatan di lingkungan rumah sakit

- (4) Merekomendasikan solusi penyelesaian atas masalah pelanggaran disiplin dan etik profesi
- (5) Memberikan rekomendasi penanganan masalah etik dalam pelaksanaan asuhan keperawatan
- (6) Merekomendasikan pencabutan kewenangan klinis staf keperawatan jika diperlukan
- (7) Merekomendasikan pencabutan surat penugasan klinis bagi staf yang melanggar ketentuan
- (8) Memberikan pertimbangan strategis dalam pengambilan keputusan etis asuhan keperawatan
- (9) Menjaga integritas dan perilaku profesional seluruh staf keperawatan di rumah sakit

KOMITE TENAGA KESEHATAN LAIN

Pasal 56

(1) Organisasi Komite

- a. Wadah organisasi non-struktural yang berfungsi mempertahankan serta meningkatkan profesionalisme tenaga keteknisan kesehatan di lingkungan rumah sakit
- b. Mekanisme penjagaan profesionalisme dilakukan melalui proses kredensial, penjagaan mutu profesi, serta pemeliharaan etika dan disiplin profesi masing-masing
- c. Pertanggungjawaban langsung kepada Direktur sebagai unit yang memastikan standar kompetensi tenaga kesehatan terpenuhi
- a. Cakupan rumpun profesi dalam Komite Tenaga Kesehatan Lain meliputi Radiografer, Ahli Gizi, Rekam Medis, Apoteker, Fisioterapis, Analis Laboratorium, dan petugas Bank Darah Rumah Sakit (BDRS)
- b. Susunan personalia komite terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Sub-Komite yang menjalankan fungsi spesifik sesuai kebutuhan profesi

(2) Kualifikasi

- a. Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lain merupakan tenaga kesehatan yang memiliki STR aktif, kompetensi sesuai bidang profesi, integritas, kemampuan kepemimpinan, serta pengalaman kerja di rumah sakit paling singkat 3 (tiga) tahun.
- b. Sekretaris Komite Tenaga Kesehatan Lain merupakan tenaga kesehatan yang memiliki STR aktif, memahami tata kelola pelayanan rumah sakit, serta mampu melaksanakan fungsi administrasi dan koordinasi komite.
- c. Anggota Komite Tenaga Kesehatan Lain berasal dari perwakilan profesi tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit dan memiliki STR aktif sesuai profesinya.
- d. Pengurus dan anggota Komite Tenaga Kesehatan Lain wajib memiliki rekam jejak yang baik, tidak sedang menjalani sanksi etik atau disiplin profesi, serta berkomitmen dalam peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
- e. Pengangkatan dan pemberhentian Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Tenaga Kesehatan Lain ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit berdasarkan ketentuan yang berlaku.

(3) Uraian Tugas

- a. Pengembangan strategi pelayanan yang mencakup aspek pendidikan, pelatihan, serta penelitian di bidang keteknisan kesehatan
- b. Transformasi pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan standar pelayanan teknis kesehatan di rumah sakit
- c. Pelaksanaan kredensial dan rekredensial untuk memverifikasi serta menetapkan kompetensi setiap tenaga kesehatan lain yang praktik di rumah sakit

- d. Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme kredensial dan rekredensial diatur lebih lanjut dalam kebijakan dan/atau peraturan internal rumah sakit yang berlaku
 - e. Pemeliharaan mutu profesi secara konsisten melalui evaluasi kinerja klinis dan pengembangan profesional berkelanjutan
- (4) Tanggung Jawab
- a. Mendukung komunikasi yang efektif antar tenaga profesional;
 - b. Menyusun kebijakan, pedoman, prosedur serta protokol, tata hubungan kerja, alur klinis, dan dokumen lain yang mengatur layanan klinis;
 - c. Menyusun kode etik profesi; dan
 - d. Memantau mutu pelayanan pasien lainnya
 - e. Penjaminan mutu pelayanan profesional dengan memastikan seluruh tenaga kesehatan lain bekerja sesuai dengan standar prosedur dan kompetensi yang telah ditetapkan
 - f. Perlindungan keselamatan pasien melalui proses verifikasi kompetensi (kredensial) yang ketat bagi seluruh staf keteknisan kesehatan
 - g. Penegakan etika dan disiplin profesi dengan melakukan pengawasan terhadap perilaku profesional anggota komite di lingkungan rumah sakit
 - h. Peningkatan kompetensi berkelanjutan melalui penyusunan program pengembangan pengetahuan dan teknologi kesehatan secara periodik
 - i. Pemberian saran profesional kepada Direksi terkait isu-isu teknis kesehatan yang berdampak pada mutu pelayanan dan kebijakan rumah sakit
 - j. Objektivitas dalam penilaian kinerja klinis guna memastikan setiap tenaga kesehatan memiliki kewenangan yang sesuai dengan kemampuan dan sertifikasinya
 - k. Pelaporan berkala kepada Direktur mengenai status kredensial, masalah etika profesi, serta hasil evaluasi mutu tenaga kesehatan lain
 - l. Penyelesaian sengketa profesi dengan memberikan pertimbangan objektif jika terjadi pelanggaran standar profesi atau disiplin di lapangan
- (5) Wewenang
- a. Pemberian rekomendasi rincian kewenangan klinis bagi setiap tenaga kesehatan lain sebagai dasar penugasan kerja
 - b. Rekomendasi pengembangan profesi melalui program pelatihan berkelanjutan bagi staf terkait
 - c. Usulan perencanaan kebutuhan tenaga serta proses penempatan personil berdasarkan hasil tinjauan profesionalisme
 - d. Usulan sarana dan prasarana yang mencakup pengadaan serta pemeliharaan fasilitas pendukung kerja tenaga kesehatan lain

KOMITE K3RS

Pasal 57

- (1) Organisasi Komite
- a. Wadah organisasi non-struktural yang membantu Direktur dalam menyelenggarakan serta mengelola program keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit
 - b. Struktur keanggotaan komite terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota yang berasal dari lintas unit kerja untuk menjamin koordinasi yang efektif
 - c. Penetapan personalia organisasi dilakukan melalui Surat Keputusan Direktur dengan mempertimbangkan kompetensi di bidang keselamatan kerja dan kesehatan lingkungan
 - d. Kedudukan koordinatif komite berada di bawah Direktur dengan kewajiban melakukan sinkronisasi program bersama seluruh unit pelayanan dan penunjang
- (2) Kualifikasi Komite K3RS

- a. Ketua Komite K3RS
 1. Mampu melakukan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan program K3RS
 2. Mendapatkan penetapan atau surat keputusan dari Direktur Rumah Sakit
 3. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan koordinasi lintas unit
- b. Sekretaris Komite
 1. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi yang baik
 2. Mampu mengoperasikan aplikasi perkantoran
 3. Memahami standar akreditasi rumah sakit terkait K3RS
- c. Koordinator Pengamanan dan Pemeliharaan Peralatan Medik
 1. Memahami manajemen peralatan medis rumah sakit.
 2. Memahami pengoperasian, pemeliharaan, dan pengamanan peralatan medis.
 3. Mampu melakukan inventarisasi dan monitoring kondisi alat kesehatan.

(3) Uraian Tugas

- a. Penyusunan program kerja K3RS secara tahunan yang mencakup identifikasi potensi bahaya serta mitigasi risiko di seluruh area rumah sakit
- b. Penyelenggaraan edukasi dan pelatihan bagi seluruh pegawai mengenai prosedur keselamatan, penanggulangan kebakaran, dan evakuasi bencana
- c. Identifikasi dan pemetaan risiko terhadap faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikososial di lingkungan kerja
- d. Pengawasan ketersediaan sarana keselamatan termasuk alat pemadam api ringan (APAR), alat pelindung diri (APD), dan sistem proteksi kebakaran lainnya
- e. Investigasi kecelakaan kerja melalui pengumpulan data, analisis penyebab, dan penyusunan rekomendasi agar kejadian serupa tidak terulang kembali
- f. Penyelenggaraan simulasi keadaan darurat secara berkala untuk menguji kesiapan staf dalam menghadapi ancaman bencana atau insiden besar

(4) Tanggung Jawab

- a. Penjaminan lingkungan kerja yang aman bagi pasien, petugas, pengunjung, serta masyarakat di sekitar lingkungan rumah sakit
- b. Kepatuhan terhadap regulasi K3 dengan memastikan rumah sakit memenuhi standar perundang-undangan kesehatan dan keselamatan kerja yang berlaku
- c. Pelaporan insiden keselamatan kerja secara berkala kepada Direktur termasuk progres perbaikan yang telah dilaksanakan
- d. Pemeliharaan budaya keselamatan di seluruh lini organisasi guna meminimalkan risiko penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja
- e. Evaluasi berkala terhadap kebijakan K3 untuk memastikan prosedur yang ada tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan risiko rumah sakit

(5) Wewenang

- a. Pemeriksaan dan inspeksi lapangan ke seluruh unit kerja guna memantau kepatuhan terhadap standar keselamatan kerja yang ditetapkan
- b. Pemberian rekomendasi penghentian aktivitas terhadap pekerjaan atau penggunaan alat yang dinilai berbahaya dan mengancam keselamatan jiwa
- c. Pengusulan perbaikan sarana dan prasarana yang berkaitan langsung dengan upaya perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja
- d. Permintaan data dan keterangan dari kepala unit kerja mengenai kondisi lingkungan serta insiden kesehatan yang terjadi di wilayah tugasnya
- e. Pemberian saran pertimbangan kepada Direksi terkait kebijakan strategis yang berdampak pada aspek keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit

KOMITE PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI)**Pasal 58****(1) Organisasi Komite**

- a. Wadah organisasi non-struktural yang dibentuk secara khusus untuk membantu Direktur dalam upaya pencegahan dan pengendalian infeksi di lingkungan rumah sakit
- b. Kedudukan dan pertanggungjawaban Komite PPI berada langsung di bawah serta bertanggung jawab secara administratif dan fungsional kepada Direktur
- c. Mekanisme pembentukan komite ditetapkan melalui Keputusan Direktur Rumah Sakit dengan mempertimbangkan masukan serta rekomendasi dari para Kepala Bidang
- d. Kolaborasi operasional dilakukan bersama Tim PPI (unsur pelaksana) untuk memastikan kebijakan yang ditetapkan terimplementasi di setiap unit pelayanan

(2) Kualifikasi Komite PPI

- a. Ketua Komite PPI
 1. Ahli atau dokter yang mempunyai minat dalam PPI.
 2. Mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar PPI.
 3. Memiliki kemampuan leadership.
- b. Sekretaris Komite PPI
 1. Perawat dengan pendidikan min S1 dan memiliki sertifikasi PPI.
 2. Memiliki komitmen di bidang pencegahan dan pengendalian infeksi.
 3. Memiliki pengalaman sebagai kepala ruangan atau setara.
 4. Memiliki kemampuan leadership, inovatif, dan confident.
 5. Bekerja penuh waktu.
- c. *IPCLN / Infection Prevention and Control Link Nurse*
 1. Perawat dengan pendidikan min D3 dan memiliki sertifikasi PPI.
 2. Memiliki komitmen di bidang pencegahan dan pengendalian infeksi.
 3. Memiliki kemampuan leadership.
- d. Anggota Komite PPI
 1. Mempunyai minat dalam PPI.
 2. Pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar PPI.

(3) Uraian Tugas

- a. Penyusunan dan sosialisasi kebijakan yang mencakup perumusan, penetapan, serta evaluasi berkala terhadap seluruh regulasi pencegahan dan pengendalian infeksi
- b. Penyediaan pedoman tata laksana berupa pembuatan standar prosedur operasional sebagai panduan teknis bagi seluruh staf dalam meminimalkan risiko infeksi
- c. Pelaksanaan investigasi KLB melalui tindakan penanggulangan masalah Kejadian Luar Biasa yang dilakukan secara sinergis bersama Tim PPI Rumah Sakit
- d. Perencanaan sarana dan prasarana yang meliputi usulan pengadaan alat serta bahan medis yang memenuhi prinsip PPI dan terjamin keamanannya bagi pengguna
- e. Pemantauan upaya pencegahan yang dilaksanakan secara rutin terhadap kepatuhan staf dan kondisi lingkungan rumah sakit
- f. Penyelenggaraan edukasi dan penyuluhan mengenai masalah infeksi kepada seluruh tenaga medis, non-medis, hingga pasien dan pengunjung rumah sakit
- g. Manajemen laporan kegiatan dengan menerima laporan dari Tim PPI untuk kemudian disusun menjadi laporan berkala kepada Direktur

(4) Tanggung Jawab

- a. Penjaminan mutu pencegahan infeksi dengan memastikan seluruh protokol PPI dilaksanakan secara konsisten di semua area rumah sakit
- b. Pemberian pertimbangan strategis kepada Direktur terkait kebijakan atau langkah-langkah krusial dalam lingkup pencegahan dan pengendalian infeksi
- c. Keamanan lingkungan pelayanan dengan memastikan risiko infeksi nosokomial (HAIs) ditekan hingga level minimal demi keselamatan pasien dan staf
- d. Validitas pelaporan berkala terhadap data surveilans dan aktivitas PPI sebagai bahan evaluasi manajemen dalam pengambilan keputusan
- e. Pengembangan kompetensi staf melalui pemantauan keberhasilan penyuluhan dan pelatihan terkait budaya cuci tangan serta penggunaan APD yang benar

(5) Wewenang

- a. Pemberian rekomendasi isolasi pasien terhadap kasus-kasus infeksius yang berisiko menular guna melindungi pasien lain serta staf rumah sakit
- b. Penghentian prosedur pelayanan yang tidak aman apabila ditemukan praktik yang menyimpang dari prinsip PPI dan berisiko tinggi menyebabkan penularan infeksi
- c. Pelaksanaan inspeksi mendadak ke seluruh unit pelayanan, termasuk dapur, laundry, dan pengelolaan limbah untuk memastikan kepatuhan terhadap standar sterilisasi
- d. Pengusulan penutupan unit atau area tertentu dalam kondisi darurat seperti terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk kepentingan dekontaminasi dan pemutusan rantai infeksi
- e. Pemberian sanksi atau teguran profesional melalui Direktur kepada staf atau unit kerja yang secara konsisten mengabaikan protokol pencegahan infeksi
- f. Pengaturan kebijakan penggunaan antimikroba yang bekerja sama dengan Komite Medik dalam rangka mengendalikan resistensi antibiotik di rumah sakit
- g. Persetujuan terhadap renovasi dan pembangunan gedung rumah sakit guna memastikan aspek rancang bangun memenuhi standar pencegahan infeksi (ICRA Konstruksi)
- h. Akses penuh terhadap data rekam medis dan hasil laboratorium yang relevan untuk kepentingan surveilans dan analisis laju infeksi rumah sakit

KOMITE MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN**Pasal 59****(1) Organisasi Komite**

- a. Pembentukan unit kerja dilakukan secara resmi oleh Direktur Rumah Sakit sebagai motor penggerak penyusunan program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)
- b. Struktur kepengurusan komite terdiri dari Ketua Komite yang membawahi dua pilar utama yaitu Sub Komite Mutu serta Sub Komite Keselamatan Pasien
- c. Kedudukan organisasi bersifat non-struktural dengan garis koordinasi langsung di bawah Direktur Rumah Sakit
- d. Sinergi antar unit dilaksanakan melalui keanggotaan yang melibatkan perwakilan dari berbagai unit kerja guna memastikan program PMKP terintegrasi di seluruh rumah sakit

(2) Kualifikasi

- a. Ketua Komite merupakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi, pengalaman, dan pemahaman di bidang peningkatan mutu, keselamatan pasien, manajemen risiko, serta tata kelola rumah sakit.

- b. Sekretaris Komite merupakan pegawai rumah sakit yang memiliki kemampuan administrasi, koordinasi, dokumentasi, pengelolaan data, dan penyusunan laporan.
- c. Sub Komite Mutu memiliki pemahaman mengenai peningkatan mutu pelayanan, indikator mutu, analisis data, clinical pathway, dan metode perbaikan mutu berkelanjutan.
- d. Sub Komite Keselamatan Pasien memiliki pemahaman mengenai keselamatan pasien, pelaporan dan analisis insiden keselamatan pasien, budaya keselamatan, serta metode RCA dan FMEA.
- e. Sub Komite Manajemen Risiko memiliki pemahaman mengenai manajemen risiko rumah sakit, identifikasi risiko, analisis risiko, mitigasi risiko, serta pemantauan dan evaluasi program manajemen risiko.
- f. Pengurus dan anggota Komite diutamakan telah mengikuti pendidikan, pelatihan, seminar, workshop, atau kegiatan pengembangan kompetensi yang berkaitan dengan mutu, keselamatan pasien, dan manajemen risiko rumah sakit.

(3) Uraian Tugas

- a. Ketua Komite bertugas menyusun rencana strategis PMKP bersama Direktur, memimpin koordinasi operasional, melakukan validasi data secara periodik, serta menyebarkan informasi peningkatan mutu melalui berbagai kanal komunikasi internal
- b. Sekretaris Komite Mutu dan Keselamatan Pasien bertugas mendukung pelaksanaan program mutu dan keselamatan pasien melalui pengelolaan administrasi, koordinasi, dokumentasi, pengumpulan data, serta penyusunan laporan guna menunjang efektivitas kegiatan Komite Mutu dan Keselamatan Pasien.
- c. Sub Komite Mutu bertugas menyusun panduan peningkatan mutu, menetapkan indikator mutu (klinis dan manajemen) bersama unit kerja, menyusun clinical pathway bersama Komite Medis, serta melakukan analisis dan validasi data capaian mutu
- d. Sub Komite Keselamatan Pasien bertugas menyusun panduan manajemen risiko, mengelola sistem pelaporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP), melaksanakan pengukuran budaya keselamatan, serta memimpin analisis akar masalah melalui metode RCA dan FMEA
- e. Sub Komite Manajemen Risiko bertugas menyusun pedoman manajemen risiko rumah sakit, mengoordinasikan identifikasi, analisis, evaluasi, dan mitigasi risiko pada seluruh unit kerja, melakukan pemantauan pelaksanaan program manajemen risiko, serta menyusun laporan dan rekomendasi perbaikan kepada Direktur dan Komite PMKP.
- f. Pengembangan kompetensi dilaksanakan dengan memberikan pelatihan berkelanjutan bagi staf yang terlibat dalam program PMKP guna meningkatkan pemahaman teknis mutu dan keselamatan

(4) Tanggung Jawab

- a. Penjaminan keberlanjutan program PMKP dengan memastikan seluruh rangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
- b. Validitas dan akurasi informasi atas seluruh data indikator mutu dan laporan insiden yang disampaikan kepada manajemen sebagai dasar pengambilan kebijakan
- c. Pertanggungjawaban kinerja dilakukan dengan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala dan formal kepada Direktur Rumah Sakit
- d. Budaya keselamatan organisasi menjadi tanggung jawab komite melalui sosialisasi nilai-nilai keselamatan pasien untuk meminimalkan risiko kejadian tidak diharapkan (KTD)

- e. Kepatuhan standar akreditasi dengan memastikan seluruh regulasi mutu dan keselamatan pasien selaras dengan standar nasional maupun internasional
- (5) Wewenang
- a. Penetapan indikator mutu prioritas rumah sakit dan unit kerja setelah melalui proses diskusi dan analisis dampak risiko
 - b. Akses terhadap data operasional dan klinis di seluruh unit kerja untuk kepentingan audit mutu, validasi data, serta investigasi insiden keselamatan pasien
 - c. Pemberian rekomendasi perbaikan kepada Direktur dan Kepala Unit terkait hasil analisis RCA atau capaian mutu yang tidak memenuhi target
 - d. Koordinasi penentuan grading risiko atas insiden yang terjadi untuk menentukan langkah tindak lanjut yang harus diambil oleh unit terkait
 - e. Pengusulan kebijakan dan prosedur (SPO) baru yang berkaitan langsung dengan upaya peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di rumah sakit

KOMITE FARMASI DAN TERAPI

Pasal 60

- (1) Organisasi Komite
- a. Wadah organisasi non-struktural yang dibentuk untuk membantu Direktur dalam mewujudkan tata kelola serta penggunaan obat yang rasional di rumah sakit
 - b. Kedudukan dan pertanggungjawaban Komite Farmasi dan Terapi berada langsung di bawah Direktur Rumah Sakit
 - c. Mekanisme pembentukan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur dengan mempertimbangkan masukan serta rekomendasi dari Kepala Bidang terkait
 - d. Sinergi keanggotaan terdiri dari tenaga medis fungsional (dokter) dan apoteker guna memastikan aspek klinis dan manajerial farmasi terpenuhi secara seimbang
- (2) Kualifikasi
- a. Ketua Komite Farmasi dan Terapi merupakan staf medis yang memiliki STR dan SIP yang masih berlaku, memahami penggunaan obat yang rasional, serta memiliki kemampuan kepemimpinan dan koordinasi lintas profesi.
 - b. Sekretaris Komite Farmasi dan Terapi merupakan apoteker yang memiliki STR dan SIPA yang masih berlaku serta memahami pengelolaan perbekalan farmasi dan penggunaan obat di rumah sakit.
 - c. Anggota Komite Farmasi dan Terapi terdiri atas dokter, dokter gigi, apoteker, perawat, dan/atau tenaga kesehatan lain yang terkait dengan penggunaan obat di rumah sakit.
- (3) Uraian Tugas
- a. Penyusunan standar terapi dan formularium yang mencakup pembuatan pedoman diagnosis, formularium rumah sakit, serta pedoman penggunaan antimikroba
 - b. Penyelenggaraan edukasi farmakoterapi berupa program pendidikan dan pelatihan terkait pengelolaan serta penggunaan obat bagi seluruh pihak terkait di rumah sakit
 - c. Pelaksanaan pengkajian obat yang meliputi evaluasi terhadap pola penggunaan obat serta pemberian umpan balik guna perbaikan kualitas pelayanan
 - d. Evaluasi produk obat baru dengan melakukan pengkajian terhadap usulan penggunaan obat atau dosis baru yang diajukan oleh anggota tenaga medis
 - e. Manajemen kategori obat khusus melalui pengelolaan protokol penggunaan obat-obatan yang memerlukan pemantauan ketat atau kriteria penggunaan tertentu

- f. Pengembangan kebijakan farmasi dengan membantu Instalasi Farmasi dalam meninjau peraturan mengenai penggunaan obat agar selaras dengan regulasi lokal maupun nasional
 - g. Pembinaan koordinasi unit dengan menjalin hubungan kerja yang harmonis antar unit kerja yang sasarannya berkaitan erat dengan penggunaan sediaan farmasi
- (4) Tanggung Jawab
- a. Penjaminan penggunaan obat yang rasional demi tercapainya efektivitas terapi, keamanan pasien (*patient safety*), dan efisiensi biaya pengobatan
 - b. Ketersediaan panduan acuan klinis dengan memastikan Formularium Rumah Sakit selalu diperbarui secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu kedokteran
 - c. Keamanan rantai penggunaan obat melalui pengawasan terhadap potensi kesalahan pemberian obat (*medication error*) dan efek samping obat yang tidak diharapkan
 - d. Kepatuhan terhadap regulasi farmasi dengan menjamin bahwa seluruh kebijakan penggunaan obat di rumah sakit tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku
 - e. Pelaporan kinerja periodik kepada Direktur mengenai evaluasi penggunaan obat serta kendala yang ditemukan dalam pengelolaan terapi di lapangan
- (5) Wewenang
- a. Penetapan daftar obat formularium melalui otoritas untuk menyetujui atau menolak usulan obat yang masuk ke dalam daftar obat resmi rumah sakit
 - b. Pemberian rekomendasi kebijakan klinis terkait penggunaan obat-obatan mahal, obat dengan risiko tinggi, maupun penggunaan antibiotik profilaksis dan terapeutik
 - c. Melakukan audit medikasi di seluruh unit pelayanan guna memastikan penggunaan obat telah sesuai dengan pedoman diagnosis dan terapi yang ditetapkan
 - d. Pengusulan pembatasan peresepan bagi tenaga medis yang tidak mematuhi kebijakan penggunaan obat rasional atau formularium rumah sakit
 - e. Intervensi teknis farmakoterapi dengan memberikan saran penggantian obat (substitusi) yang lebih efektif dan efisien berdasarkan pertimbangan ilmiah

KOMITE PROGRAM PENGENDALIAN RESISTENSI ANTIMIKROBA

Pasal 61

- (1) Organisasi Komite
- a. Wadah organisasi non-struktural yang dibentuk untuk mengoordinasikan upaya pengendalian resistensi antimikroba di rumah sakit secara terpadu
 - b. Keanggotaan lintas disiplin yang melibatkan berbagai unsur profesional termasuk Dokter Spesialis, Apoteker, Mikrobiologi Klinik, Perawat, dan Komite PPI
 - c. Kedudukan fungsional yang berada di bawah kepemimpinan yang ditunjuk dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Rumah Sakit
 - d. Kolaborasi strategis yang mengintegrasikan peran apoteker dan tenaga kesehatan lainnya dalam mempromosikan penggunaan antimikroba secara bijak
- (2) Kualifikasi
- a. Ketua
 - 1. Merupakan dokter yang memiliki STR dan SIP yang masih berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2. Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pengendalian resistensi antimikroba, penggunaan antibiotik secara bijak, serta pencegahan dan pengendalian infeksi.

3. Memiliki kemampuan kepemimpinan, koordinasi, analisis, dan evaluasi program mutu pelayanan klinis.
4. Mampu menyusun kebijakan, pedoman, serta rekomendasi terkait penggunaan antimikroba di rumah sakit.
5. Memiliki komitmen terhadap peningkatan mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan penggunaan antibiotik yang rasional.
- b. Sekretaris
 1. Merupakan tenaga kesehatan atau tenaga administrasi yang ditunjuk oleh Direktur Rumah Sakit.
 2. Memiliki kemampuan administrasi, dokumentasi, pengarsipan, dan pelaporan program.
 3. Mampu mengelola data, menyusun laporan kegiatan, serta melakukan koordinasi dengan unit terkait.
 4. Memahami program pengendalian resistensi antimikroba dan tata kelola rumah sakit.
- c. Koordinator Pelatihan
 1. Merupakan tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan komunikasi, edukasi, dan fasilitasi pelatihan.
 2. Memahami prinsip penggunaan antibiotik secara bijak dan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba.
 3. Mampu merencanakan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi kegiatan sosialisasi, pelatihan, serta pendidikan terkait PPRA.
- d. Koordinator Surveilans
 1. Merupakan tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data.
 2. Memahami surveilans penggunaan antibiotik, surveilans mikroorganisme penyebab infeksi, dan pola resistensi antimikroba.
 3. Mampu menyusun laporan indikator mutu, laporan surveilans, dan pelaporan program sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Koordinator Program Pengelolaan Antimikroba (PGA)
 1. Merupakan dokter yang memiliki kompetensi dalam tata laksana penyakit infeksi dan penggunaan antimikroba secara rasional.
 2. Memiliki kemampuan melakukan kajian klinis, audit penggunaan antibiotik, serta pemberian rekomendasi terapi antimikroba.
 3. Mampu memberikan umpan balik kepada tenaga medis mengenai penggunaan antibiotik yang tepat sesuai indikasi klinis.
 4. Memiliki kemampuan memimpin diskusi atau forum kajian kasus penyakit infeksi secara terintegrasi.
- f. Anggota
 1. Merupakan tenaga kesehatan dan/atau tenaga medis yang ditunjuk oleh Direktur Rumah Sakit sesuai kebutuhan program.
 2. Memiliki kompetensi sesuai bidang profesi masing-masing serta memahami prinsip penggunaan antibiotik secara bijak.
 3. Berkomitmen menerapkan kewaspadaan standar, pencegahan dan pengendalian infeksi, serta mendukung pelaksanaan program PPRA.
 4. Mampu berpartisipasi dalam penyusunan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program pengendalian resistensi antimikroba di unit kerjanya.
 5. Memiliki kemampuan bekerja sama dan berkoordinasi dengan profesi lain dalam pelaksanaan program PPRA.

(3) Uraian Tugas

- a. Implementasi kebijakan pengendalian dengan menerapkan strategi resistensi antimikroba yang terintegrasi dengan empat pilar utama (Farmasi Klinis, Mikrobiologi, PPI, dan Klinisi)
- b. Penyusunan program kerja PPRA yang mencakup rencana aksi tahunan dalam rangka menekan angka resistensi bakteri di lingkungan rumah sakit
- c. Penyelenggaraan forum diskusi klinis melalui kajian kasus pengelolaan penderita penyakit infeksi secara berkala dan terintegrasi

- d. Penyebarluasan informasi dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran tenaga medis mengenai prinsip penggunaan antimikroba yang bijak
 - e. Pengembangan riset dan penelitian yang berkaitan dengan pengendalian resistensi antimikroba guna mendukung kebijakan berbasis bukti (evidence-based)
 - f. Monitoring dan evaluasi program secara berkelanjutan untuk menilai efektivitas kebijakan penggunaan antimikroba yang telah ditetapkan
- (4) Tanggung Jawab
- a. Penetapan kebijakan penggunaan antimikroba agar seluruh pemberian terapi antibiotik di rumah sakit dilakukan secara rasional dan tepat indikasi
 - b. Pengendalian penyebaran bakteri resisten melalui pengawasan ketat terhadap pola kepekaan bakteri dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan
 - c. Penjaminan efektivitas terapi infeksi dengan memastikan pasien mendapatkan antimikroba yang sesuai sehingga meminimalkan risiko kegagalan pengobatan
 - d. Pelaporan kinerja secara periodik kepada Direktur mengenai perkembangan pola resistensi dan pencapaian program PPRA di rumah sakit
 - e. Keberlanjutan edukasi profesional dengan menjamin tersedianya pelatihan bagi tenaga kesehatan terkait prinsip pengendalian resistensi
- (5) Wewenang
- a. Penyelenggaraan kajian kasus terintegrasi untuk mengevaluasi pengelolaan penyakit infeksi yang kompleks di unit pelayanan
 - b. Pelaksanaan surveilans penggunaan antibiotik baik secara kuantitatif (metode DDD) maupun kualitatif (metode Gyssens) di seluruh lini rumah sakit
 - c. Surveilans pola mikroba dan kepekaan melalui kerja sama dengan laboratorium mikrobiologi untuk memantau tren resistensi antibiotik
 - d. Intervensi pendidikan dan pelatihan dengan memberikan instruksi terkait ketaatan terhadap pencegahan pengendalian infeksi dan penggunaan antibiotik bijak
 - e. Pemberian rekomendasi kebijakan terapi kepada Direktur dan tenaga medis berdasarkan hasil surveilans pola kuman dan sensitivitas antibiotik lokal rumah sakit

KOMITE ETIK

Pasal 62

- (1) Organisasi Komite
- a. Wadah organisasi non-struktural yang dibentuk untuk membantu Direktur dalam mengelola aspek etika rumah sakit serta menangani isu-isu hukum (medisolegal)
 - b. Kedudukan dan pertanggungjawaban Komite Etik dan Hukum berada langsung di bawah serta bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit
 - c. Mekanisme pembentukan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur dengan mempertimbangkan masukan serta aspirasi dari para Kepala Bidang
 - d. Sifat keanggotaan terdiri dari personil yang memiliki integritas dan pemahaman di bidang etika profesi serta regulasi hukum kesehatan
- (2) Kualifikasi
- a. Ketua Komite Etik merupakan tenaga profesional yang memiliki integritas, keteladanan, kemampuan kepemimpinan, serta pemahaman yang baik mengenai etika profesi, etika pelayanan rumah sakit, dan peraturan perundang-undangan yang terkait.
 - b. Sekretaris Komite Etik merupakan pegawai rumah sakit yang memiliki kemampuan administrasi, koordinasi, dokumentasi, serta pemahaman mengenai pelaksanaan fungsi dan tugas Komite Etik.

- c. Anggota Komite Etik terdiri atas unsur profesi yang ada di rumah sakit dan/atau pihak lain yang memiliki kompetensi serta pemahaman di bidang etika profesi, hukum kesehatan, tata kelola rumah sakit, atau disiplin ilmu lain yang relevan.
- (3) Uraian Tugas
- a. Sosialisasi kewajiban rumah sakit yang mencakup pemenuhan kewajiban umum, tanggung jawab terhadap masyarakat, serta pemenuhan hak dan kewajiban staf
 - b. Penyelesaian masalah medisolegal melalui pendampingan dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait atas penugasan dari Direktur
 - c. Penyelenggaraan komunikasi etikolegal baik secara internal antar unit kerja maupun eksternal dengan pihak di luar rumah sakit
 - d. Peningkatan literasi hukum dan etika bagi seluruh petugas rumah sakit guna meminimalkan risiko pelanggaran perilaku dan regulasi
 - e. Pemberian rekomendasi tertulis kepada Direktur sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait masalah etika dan hukum yang terjadi
 - f. Manajemen risiko etikolegal melalui pengembangan kemampuan identifikasi dan mitigasi terhadap potensi masalah hukum di lingkungan rumah sakit
- (4) Tanggung Jawab
- a. Penegakan etika rumah sakit dengan memastikan seluruh unsur di dalam rumah sakit berperilaku sesuai dengan kode etik yang berlaku
 - b. Keadilan dan transparansi dalam menengahi sengketa atau masalah etika yang melibatkan pasien, staf, maupun manajemen
 - c. Perlindungan reputasi institusi melalui penyelesaian masalah hukum secara profesional dan sesuai dengan koridor perundang-undangan
 - d. Kualitas rekomendasi kebijakan dengan memastikan setiap saran yang diberikan kepada Direktur didasarkan pada analisis yang objektif dan komprehensif
 - e. Kerahasiaan informasi atas seluruh kasus medisolegal dan etika yang ditangani agar tidak berdampak negatif pada privasi pihak-pihak yang terlibat
- (5) Wewenang
- a. Melakukan peninjauan kasus etika dan hukum atas permintaan Direktur untuk menentukan langkah-langkah penyelesaian yang tepat
 - b. Meminta keterangan dan bukti dari unit kerja atau personil terkait guna mendalami permasalahan medisolegal yang sedang diinvestigasi
 - c. Memberikan saran dan masukan terkait draf kebijakan atau peraturan internal rumah sakit agar tidak bertentangan dengan hukum dan etika publik
 - d. Melakukan koordinasi dengan penasihat hukum atau lembaga eksternal atas izin Direktur dalam rangka penyelesaian sengketa hukum
 - e. Mengusulkan sanksi atau tindakan korektif terhadap pelanggaran etika yang dilakukan oleh unsur-unsur di dalam rumah sakit sesuai dengan derajat pelanggarannya

TIM REVIEW REKAM MEDIS

Pasal 63

- (1) Organisasi Komite
- a. Wadah organisasi fungsional yang dibentuk untuk mengawasi dan mengembangkan standar penyelenggaraan rekam medis serta sistem informasi manajemen di rumah sakit
 - b. Kedudukan tim berada dalam struktur koordinatif yang berfokus pada penguatan aspek administratif dan klinis melalui data rekam medis yang akurat
 - c. Sinergi antar profesi yang melibatkan para praktisi rekam medis, tenaga teknologi informasi, serta perwakilan tenaga medis untuk menjamin kualitas dokumentasi pelayanan
 - d. Mekanisme kerja yang berlandaskan pada integrasi antara pelayanan pasien rawat jalan maupun rawat inap dengan sistem informasi manajemen rumah sakit

(2) Uraian Tugas

- a. Melakukan penilaian terhadap kelengkapan pengisian Rekam Medis Elektronik (eRM) sesuai standar yang berlaku di rumah sakit.
- b. Menilai keterbacaan, kebenaran, dan kesesuaian isi dokumen eRM untuk menjamin mutu informasi klinis.
- c. Memantau ketepatan waktu pengembalian dan penyelesaian pengisian eRM oleh unit pelayanan terkait.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi mutu pengelolaan eRM secara berkala sebagai bagian dari peningkatan mutu pelayanan.
- e. Memberikan umpan balik serta rekomendasi perbaikan kepada unit terkait atas temuan dalam proses review eRM.
- f. Berkoordinasi dengan unit/unit kerja lain dalam rangka peningkatan kepatuhan dan standardisasi pengisian eRM.
- g. Menyusun laporan hasil review eRM secara berkala sebagai bahan evaluasi manajemen rumah sakit.

(3) Tanggung Jawab

- a. Penjaminan mutu rekam medis dengan memastikan setiap dokumen rekam medis memenuhi standar kelengkapan, keakuratan, dan tepat waktu
- b. Standardisasi dan administrasi terhadap seluruh proses pengelolaan data medis agar sesuai dengan regulasi nasional yang berlaku
- c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengawasan terhadap kompetensi dan profesionalisme staf di unit rekam medis
- d. Optimalisasi sumber daya pendukung termasuk pemeliharaan dan peningkatan sistem informasi serta perangkat lain yang menunjang operasional rekam medis
- e. Validitas laporan kinerja sebagai dasar bagi manajemen dalam menilai efektivitas sistem informasi di rumah sakit

(4) Wewenang

- a. Pengaturan rencana kegiatan secara mandiri dalam lingkup penyelenggaraan Unit Sistem Informasi Manajemen dan Rekam Medis
- b. Penilaian dan motivasi anggota melalui otoritas untuk mengevaluasi kinerja staf serta memberikan dorongan profesional demi pencapaian target unit
- c. Pengusulan pengembangan SDM dengan merekomendasikan program pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi staf yang memerlukan peningkatan kompetensi
- d. Usulan pengadaan sarana dan logistik yang meliputi kebutuhan perangkat keras, perangkat lunak, alat pendukung, serta kebutuhan logistik lainnya di unit rekam medis

TIM PONEK

Pasal 64**(1) Organisasi**

- a. Wadah organisasi fungsional yang dibentuk untuk menyelenggarakan pelayanan kegawatdaruratan bagi ibu dan bayi secara terpadu selama 24 jam di rumah sakit
- b. Struktur keanggotaan multidisiplin yang terdiri dari Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi, Dokter Spesialis Anak, Dokter Anestesi, Bidan, serta Perawat terlatih
- c. Kedudukan operasional berada di bawah koordinasi Direktur untuk memastikan kesiapan rumah sakit sebagai pusat rujukan pelayanan kesehatan ibu dan bayi
- d. Sinergi unit kerja yang menghubungkan Instalasi Gawat Darurat, Kamar Bersalin, Kamar Operasi, serta unit perawatan intensif bayi (NICU)

(2) Uraian Tugas

- a. Penyusunan regulasi internal yang mencakup pembuatan kebijakan, pedoman, serta standar prosedur operasional terkait penerapan program PONEK

- b. Penerapan standar pelayanan terpadu untuk menjamin perlindungan ibu dan bayi melalui mekanisme pelayanan yang sesuai dengan protokol kesehatan nasional
 - c. Peningkatan kesiapan gawat darurat dengan memastikan ketersediaan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia untuk fungsi PONEK 24 jam
 - d. Implementasi program unggulan melalui peran rumah sakit sebagai pembina teknis Inisiasi Menyusui Dini (IMD), ASI Eksklusif, serta Perawatan Metode Kanguru (PMK) pada bayi berat lahir rendah
 - e. Pemantauan program RSSIB melalui evaluasi pelaksanaan 10 langkah menuju keberhasilan menyusui dan peningkatan kesehatan ibu secara menyeluruh
 - f. Analisis indikator klinis yang meliputi pemantauan angka kematian ibu dan anak, keterlambatan operasi *Sectio Caesarea*, serta kejadian tidak dilakukannya IMD
 - g. Pengembangan fungsi rujukan dengan memposisikan rumah sakit sebagai pusat konsultasi dan rujukan bagi sarana pelayanan kesehatan primer lainnya
- (3) Tanggung Jawab
- a. Pelaksanaan program sesuai pedoman dengan memastikan seluruh kegiatan PONEK berjalan selaras dengan standar nasional yang berlaku
 - b. Keberhasilan target penurunan AKI dan AKB melalui intervensi medis yang cepat, tepat, dan berkualitas pada kasus kegawatdaruratan
 - c. Kualitas pelayanan neonatal dan obstetri dengan menjamin keselamatan pasien melalui pengawasan mutu pelayanan secara konsisten
 - d. Validitas data dan pelaporan atas hasil analisis angka kematian dan indikator mutu pelayanan kebidanan serta anak kepada manajemen
 - e. Keberlangsungan edukasi pasien dengan menjamin setiap ibu mendapatkan informasi dan dukungan yang cukup mengenai kesehatan bayi dan pemberian ASI
- (4) Wewenang
- a. Instruksi penugasan staf untuk memerintahkan dan menugaskan personil terkait dalam pelaksanaan program pelayanan obstetri neonatal emergensi komprehensif
 - b. Permintaan laporan kinerja unit terhadap seluruh bagian yang terlibat dalam rantai pelayanan PONEK guna evaluasi program secara menyeluruh
 - c. Koordinasi lintas sektoral di lingkungan rumah sakit untuk memastikan kelancaran alur pelayanan dari gawat darurat hingga ruang perawatan
 - d. Akses data dan informasi terkait dari unit-unit kerja lain yang berhubungan dengan data pelayanan ibu dan bayi untuk kepentingan audit dan analisis
 - e. Komunikasi internal dan eksternal melalui korespondensi resmi, media elektronik, maupun telekomunikasi guna kelancaran rujukan dan koordinasi medis

TIM TB DOTS

Pasal 65

(1) Organisasi

- a. Wadah organisasi fungsional yang dibentuk untuk mengelola dan menyelenggarakan program penanggulangan tuberkulosis secara terpadu di rumah sakit
- b. Struktur tim multidisiplin yang terdiri dari dokter spesialis paru/penyakit dalam, perawat, petugas laboratorium, farmasi, dan tenaga promosi kesehatan
- c. Kedudukan operasional berada di bawah koordinasi Direktur guna memastikan standar pelayanan TB sesuai dengan strategi nasional
- d. Sinergi unit kerja yang menghubungkan poliklinik TB, laboratorium mikrobiologi, instalasi farmasi, dan unit rawat inap dalam satu sistem informasi terintegrasi

(2) Uraian Tugas

- a. Penyusunan regulasi internal terkait penerapan program TB DOTS yang meliputi pembuatan kebijakan, pedoman kerja, dan standar prosedur operasional
- b. Pelaksanaan promosi kesehatan yang diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan komprehensif mengenai TB kepada pasien, keluarga, pengunjung, serta staf rumah sakit
- c. Penyelenggaraan surveilans tuberkulosis untuk memperoleh data epidemiologi yang akurat guna mendukung sistem pencatatan dan pelaporan TB, termasuk TB Resistensi Obat (TB-RO)
- d. Pengendalian faktor risiko dengan menjalankan protokol pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) tuberkulosis di seluruh lingkungan rumah sakit
- e. Monitoring dan panduan unit untuk memastikan setiap unit kerja menerapkan program pengendalian tuberkulosis sesuai dengan standar yang ditetapkan
- f. Penyelenggaraan imunisasi dan profilaksis melalui pemberian obat pencegahan serta peningkatan kekebalan bagi populasi berisiko sesuai ketentuan medis
- g. Evaluasi pengobatan dan imunisasi dengan melakukan monitoring berkala terhadap efektivitas pemberian obat anti tuberkulosis (OAT) dan hasil imunisasi

(3) Tanggung Jawab

- a. Pelaksanaan pelayanan TB Paru dengan memastikan seluruh tahapan diagnosis dan pengobatan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Keberhasilan angka kesembuhan melalui pengawasan kepatuhan minum obat pasien guna mencegah terjadinya putus obat (drop out)
- c. Keakuratan sistem pelaporan terhadap data logistik OAT, hasil pemeriksaan laboratorium, dan status akhir pengobatan pasien TB
- d. Pencegahan transmisi infeksi dengan bertanggung jawab atas terciptanya lingkungan rumah sakit yang aman dari risiko penularan kuman tuberkulosis
- e. Pencapaian indikator mutu program nasional penanggulangan TB yang ditetapkan oleh pemerintah dan manajemen rumah sakit

(4) Wewenang

- a. Pengambilan keputusan kebijakan terkait program TB DOTS di tingkat rumah sakit dengan merujuk pada regulasi dan perundangan yang berlaku
- b. Akses data dan informasi anggota untuk melakukan audit internal maupun evaluasi kinerja tim terkait jalannya program
- c. Permintaan laporan pelaksanaan dari seluruh unit kerja pelaksana guna memantau perkembangan dan kendala pelayanan TB di rumah sakit
- d. Koordinasi lintas sektoral di lingkungan rumah sakit untuk mengintegrasikan layanan TB dengan unit-unit penunjang lainnya
- e. Permintaan data pendukung dari berbagai unit kerja yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pelayanan TB untuk kepentingan analisis epidemiologi

Tim HIV
Pasal 66

(1) Organisasi

- a. Wadah organisasi fungsional yang dibentuk sebagai motor penggerak dalam penyusunan dan pelaksanaan program penanggulangan HIV/AIDS di rumah sakit
- b. Struktur tim multidisiplin yang mengintegrasikan berbagai unsur pelayanan seperti Dokter Spesialis, Konselor VCT (Voluntary Counseling and Testing), Perawat, Farmasi, Laboratorium, dan petugas Rekam Medis

- c. Kedudukan koordinatif yang berfungsi menyatukan seluruh kegiatan pelayanan HIV/AIDS di berbagai unit kerja agar berjalan secara terpadu dan sistematis
 - d. Sistem informasi terintegrasi yang dikelola oleh tim untuk menyatukan pelaporan kegiatan pelayanan HIV/AIDS dari seluruh departemen terkait
- (2) Uraian Tugas
- a. Penyusunan regulasi internal yang meliputi pembuatan kebijakan dan prosedur operasional terkait penerapan program penanggulangan HIV/AIDS di rumah sakit
 - b. Koordinasi dan integrasi kegiatan dengan memastikan seluruh unit kerja menjalankan program HIV/AIDS secara seraras di seluruh area rumah sakit
 - c. Monitoring dan panduan penerapan melalui pendampingan teknis kepada unit kerja dalam menjalankan standar pelayanan HIV/AIDS yang ditetapkan
 - d. Pengawasan dan supervisi data terhadap kemajuan pengumpulan data pengukuran untuk indikator prioritas yang telah dipilih oleh manajemen rumah sakit
 - e. Manajemen komunikasi strategis dengan menjalin hubungan baik kepada pihak terkait serta menyampaikan isu atau masalah dalam pelaksanaan program
 - f. Keterlibatan klinis dan sosial dalam menangani masalah pelayanan yang muncul serta melakukan advokasi terhadap pelayanan HIV/AIDS yang berkualitas
- (3) Tanggung Jawab
- a. Penanggulangan HIV/AIDS sesuai standar dengan menjamin seluruh pelayanan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - b. Keberlangsungan sistem pelaporan melalui integrasi data kegiatan pelayanan yang akurat dan tepat waktu untuk kepentingan pelaporan internal maupun nasional
 - c. Pencapaian indikator prioritas rumah sakit dengan memastikan setiap progres pengukuran data menunjukkan kemajuan yang sesuai dengan target
 - d. Kualitas komunikasi antarsektor guna memastikan kendala dalam pelayanan HIV/AIDS dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan
 - e. Kepatuhan unit kerja terhadap program melalui fungsi bimbingan dan pengawasan agar setiap unit menjalankan peran masing-masing dalam program HIV/AIDS
- (4) Wewenang
- a. Pengambilan keputusan kebijakan dalam menetapkan regulasi yang berlaku untuk program HIV/AIDS sesuai dengan koridor hukum yang berlaku
 - b. Akses data dan informasi internal guna meminta keterangan dari anggota tim maupun unit kerja terkait mengenai jalannya program HIV/AIDS
 - c. Permintaan laporan pelaksanaan dari unit kerja pelaksana untuk mengevaluasi efektivitas pelayanan HIV/AIDS di rumah sakit
 - d. Koordinasi lintas unit di lingkungan rumah sakit untuk mensinkronkan langkah-langkah pelayanan dan penanggulangan HIV/AIDS
 - e. Verifikasi data pelayanan dengan meminta informasi yang berhubungan langsung dengan pelayanan HIV/AIDS dari seluruh lini kerja di lingkungan rumah sakit

Tim Geriatri
Pasal 67

- (1) Organisasi
- a. Wadah pelayanan terpadu yang dibentuk untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi pasien lanjut usia dengan pendekatan multidisiplin yang komprehensif
 - b. Struktur tim terpadu yang terdiri dari dokter spesialis (Geriatri/Penyakit Dalam), perawat, fisioterapis, ahli gizi, apoteker, serta tenaga kesehatan lain yang terkait

- c. Model koordinasi interdisiplin yang menghubungkan berbagai Kelompok Staf Medik Fungsional (KSMF) dan departemen di rumah sakit untuk menangani masalah kompleks pada lansia
 - d. Kedudukan organisasi berada di bawah arahan Direktur guna memastikan tersedianya sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang ramah lansia
- (2) Uraian Tugas
- a. Penyusunan rencana kebutuhan mencakup perencanaan kerja tahunan serta usulan kebutuhan ketenagaan dan fasilitas pendukung tim geriatri
 - b. Penyelenggaraan pelayanan geriatri yang dilaksanakan berdasarkan kebijakan Direktur dan disesuaikan dengan tingkatan pelayanan rumah sakit
 - c. Pengelolaan sistem rujukan baik rujukan internal antar unit maupun rujukan ke dan dari luar rumah sakit guna menjamin kesinambungan pelayanan
 - d. Koordinasi lintas sektoral melalui kerja sama dengan tim atau departemen lain di dalam rumah sakit serta hubungan lintas program melalui jalur Direktur
 - e. Monitoring dan evaluasi pelayanan yang dilakukan secara berkala terhadap seluruh aktivitas pelayanan geriatri yang diberikan kepada pasien
 - f. Analisis data dan pelaporan berupa pengolahan hasil monitoring ke dalam bentuk laporan kinerja untuk disampaikan secara rutin kepada Direktur
 - g. Pembinaan komunitas dengan melakukan edukasi dan bimbingan terhadap kelompok atau komunitas lanjut usia terkait di wilayah cakupan rumah sakit
- (3) Tanggung Jawab
- a. Penyelenggaraan pelayanan geriatri yang bermutu sesuai dengan kemampuan, sumber daya, serta standar sarana dan prasarana yang tersedia di rumah sakit
 - b. Keberhasilan tata kelola pasien lansia melalui pendekatan paripurna guna meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian pasien lanjut usia
 - c. Efektivitas koordinasi interdisiplin dengan menjamin setiap disiplin ilmu bekerja sama secara harmonis dalam memberikan intervensi medis
 - d. Validitas laporan berkala yang mencerminkan capaian program dan kendala di lapangan sebagai bahan evaluasi manajemen
 - e. Kepatuhan terhadap standar pelayanan dengan memastikan seluruh aktivitas tim geriatri selaras dengan peraturan perundangan yang berlaku
- (4) Wewenang
- a. Pengambilan keputusan kebijakan dalam lingkup program geriatri di rumah sakit dengan merujuk pada regulasi dan perundangan yang berlaku
 - b. Akses data dan informasi internal untuk meminta keterangan dari anggota tim maupun unit kerja terkait mengenai jalannya pelayanan geriatri
 - c. Permintaan laporan pelaksanaan dari setiap unit kerja pelaksana guna memantau perkembangan program pelayanan geriatri secara menyeluruh
 - d. Koordinasi lintas unit kerja di lingkungan rumah sakit untuk mensinkronkan langkah-langkah pelayanan terpadu bagi pasien lansia
 - e. Verifikasi informasi operasional dengan meminta data yang berhubungan dengan pelayanan geriatri dari seluruh bagian di lingkungan rumah sakit

Tim PKBRS
Pasal 68

(1) Organisasi

- a. Wadah organisasi fungsional yang dibentuk sebagai bagian integral dari program nasional Keluarga Berencana guna menurunkan angka kematian ibu
- b. Struktur tim lintas unit yang melibatkan dokter spesialis obstetri dan ginekologi, bidan, perawat, serta tenaga administrasi medis
- c. Kedudukan operasional berada di bawah koordinasi Direktur untuk memastikan integrasi layanan KB dalam alur pelayanan rumah sakit

- d. Model pelayanan terpadu yang menghubungkan unit rawat jalan, kamar bersalin (VK), dan unit rawat inap pasca persalinan
- (2) Uraian Tugas
- a. Penyusunan rencana program kerja yang mencakup strategi pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit secara tahunan
 - b. Pengembangan regulasi dan standar melalui pembuatan kebijakan serta Standar Prosedur Operasional (SPO) guna meningkatkan kualitas pelayanan KB
 - c. Penyelenggaraan pelayanan paripurna dengan menerapkan standar pelayanan KB yang terintegrasi, termasuk metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)
 - d. Peningkatan kesiapan institusi dalam melaksanakan fungsi PKBRS, khususnya pada pelayanan KB Pasca Persalinan (KBPP) dan Pasca Keguguran
 - e. Manajemen administrasi dan pengarsipan yang sistematis terkait seluruh dokumen, laporan, dan data pasien dalam lingkup tim PKBRS
 - f. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program kerja guna memastikan target capaian program nasional terpenuhi
- (3) Tanggung Jawab
- a. Penurunan angka kematian ibu melalui promosi dan penyediaan layanan kontrasepsi yang tepat bagi pasien rumah sakit
 - b. Kepatuhan terhadap standar pelayanan dengan menjamin seluruh tindakan KB dilakukan sesuai dengan prosedur medis dan regulasi yang berlaku
 - c. Keberlangsungan program KB pasca persalinan dengan memastikan setiap ibu yang melahirkan mendapatkan edukasi dan akses kontrasepsi sebelum pulang
 - d. Validitas data pelaporan terhadap manajemen dan instansi luar terkait cakupan peserta KB baru dan KB aktif di rumah sakit
 - e. Kualitas edukasi pasien dengan memberikan informasi yang benar dan objektif mengenai pilihan metode kontrasepsi kepada pasien dan keluarga
- (4) Wewenang
- a. Penetapan agenda rapat strategis untuk menentukan arah kebijakan dan penyelesaian masalah dalam operasional Tim PKBRS
 - b. Instruksi penugasan staf dalam menjalankan program pelayanan kesehatan KB di berbagai unit terkait di rumah sakit
 - c. Koordinasi lintas unit kerja di lingkungan rumah sakit guna memastikan alur pelayanan KB berjalan lancar tanpa hambatan birokrasi
 - d. Akses data dan informasi medis yang berhubungan dengan pelayanan KB dari seluruh unit kerja untuk kepentingan evaluasi dan pelaporan
 - e. Pelaksanaan investigasi internal terhadap proses pelayanan KB jika ditemukan ketidaksesuaian standar atau adanya keluhan pelanggan

Tim Stunting dan Wasting
Pasal 69

- (1) Organisasi
- a. Wadah organisasi fungsional yang dibentuk sebagai bagian dari program nasional untuk menurunkan prevalensi stunting dan wasting melalui intervensi gizi spesifik di rumah sakit
 - b. Struktur tim multidisiplin yang melibatkan dokter spesialis anak, dokter spesialis gizi klinik, ahli gizi (dietisien), perawat, serta tenaga farmasi

- c. Kedudukan operasional berada di bawah koordinasi Direktur guna memastikan program layanan kesehatan dan gizi berjalan secara terpadu dengan unit pelayanan terkait
- d. Jejaring pelayanan yang menghubungkan layanan internal rumah sakit dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) serta komunitas di wilayah kerja rumah sakit

(2) Uraian Tugas

- a. Penyusunan rencana program kerja yang mencakup strategi intervensi gizi, jadwal kegiatan, dan target capaian Tim Stunting dan Wasting secara tahunan
- b. Pengembangan pedoman dan standar melalui pembuatan panduan kerja serta Standar Prosedur Operasional (SPO) terkait layanan kesehatan dan gizi pencegahan stunting
- c. Penyediaan materi edukasi dalam berbagai bentuk sebagai sarana Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) bagi pasien serta keluarga dalam upaya preventif dan promotif
- d. Monitoring dan investigasi pelayanan terhadap proses asuhan gizi dan kesehatan di rumah sakit untuk memastikan kepatuhan terhadap standar cegah stunting
- e. Pemantauan eksternal melalui koordinasi ke FKTP dan komunitas terkait guna menjamin kesinambungan pelayanan gizi pasien pasca rawat atau rujukan
- f. Analisis dan tindak lanjut dengan mengusulkan perbaikan strategis berdasarkan hasil pemantauan pelayanan kesehatan gizi di lapangan
- g. Evaluasi kegiatan periodik untuk menilai efektivitas program stunting dan wasting yang dilaksanakan di lingkungan Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo

(3) Tanggung Jawab

- a. Penurunan prevalensi stunting dan wasting melalui intervensi medis dan gizi yang tepat pada sasaran pasien anak di rumah sakit
- b. Kualitas intervensi gizi dengan memastikan pemberian nutrisi dan tata laksana medis dilakukan secara kuratif dan rehabilitatif sesuai standar klinis
- c. Keakuratan data surveilans gizi sebagai dasar pelaporan progres penurunan stunting kepada manajemen dan instansi kesehatan terkait
- d. Efektivitas edukasi keluarga dengan menjamin peningkatan pengetahuan pasien mengenai pola asuh dan pola makan yang benar untuk pencegahan stunting
- e. Keselarasan program nasional dengan memastikan seluruh aktivitas tim sejalan dengan regulasi pencegahan stunting yang ditetapkan pemerintah

(4) Wewenang

- a. Penetapan agenda rapat strategis guna menentukan prioritas kerja dan pemecahan masalah dalam operasional Tim Stunting dan Wasting
- b. Instruksi penugasan staf dalam pelaksanaan program pelayanan kesehatan dan gizi di seluruh unit pelayanan yang terkait
- c. Akses data dan informasi anggota untuk melakukan evaluasi internal terhadap kinerja personil yang terlibat dalam tim
- d. Pengambilan keputusan kebijakan dalam menetapkan aturan pelaksanaan program sesuai dengan perundangan dan regulasi yang berlaku
- e. Permintaan laporan unit pelaksana terhadap progres pelayanan kesehatan gizi guna memastikan sinkronisasi data antar unit kerja
- f. Koordinasi lintas sektoral di lingkungan rumah sakit untuk mengintegrasikan layanan gizi dengan unit rawat jalan, rawat inap, dan IGD
- g. Verifikasi informasi klinis dengan meminta data yang berhubungan dengan pelayanan stunting dan wasting dari seluruh bagian di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo

Tim HTA

Pasal 70

(1) Organisasi

- a. Wadah organisasi fungsional yang dibentuk untuk melakukan evaluasi sistematis terhadap penggunaan teknologi kesehatan di rumah sakit guna menjamin efektivitas dan efisiensi
- b. Keanggotaan tim ahli yang terdiri dari multidisiplin ilmu termasuk klinisi, farmasi, manajemen rumah sakit, dan tenaga teknis pendukung
- c. Kedudukan strategis yang berfungsi sebagai pemberi rekomendasi kepada Direktur dalam proses pengadaan atau penggunaan teknologi medis baru maupun yang sedang berjalan
- d. Sistem pendukung keputusan yang menghubungkan aspek klinis (keamanan dan efikasi) dengan aspek ekonomi (biaya) dalam operasional rumah sakit

(2) Uraian Tugas

- a. Penyusunan rencana dan program yang meliputi pembuatan rencana kerja, anggaran, evaluasi, serta penyediaan data dan informasi kegiatan HTA secara periodik
- b. Penilaian dan pengkajian teknologi dengan melakukan analisis mendalam terhadap alat kesehatan, obat, maupun prosedur medis yang digunakan di rumah sakit
- c. Pengembangan kompetensi internal melalui peningkatan keahlian anggota tim dan staf operasional dalam metode penapisan teknologi kesehatan terbaru
- d. Pengawasan program penapisan melalui pemantauan dan pengarahan terhadap seluruh kegiatan evaluasi teknologi dalam jangka waktu yang telah ditentukan
- e. Pengolahan dan keputusan hasil dengan melakukan penilaian teknis yang adekuat guna menghasilkan simpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan
- f. Pelaporan dan rekomendasi dengan menyampaikan hasil kajian secara formal kepada pimpinan sebagai dasar pengambilan kebijakan teknologi kesehatan

(3) Tanggung Jawab

- a. Pengembangan program penapisan dengan memastikan sistem evaluasi teknologi kesehatan di rumah sakit berjalan sesuai standar dan metodologi yang berlaku
- b. Keakuratan hasil kajian terhadap efektivitas klinis dan keamanan teknologi guna melindungi pasien dari risiko medis yang tidak perlu
- c. Efisiensi anggaran rumah sakit dengan memastikan teknologi yang dipilih memiliki nilai manfaat yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan (*cost-effective*)
- d. Transparansi proses penapisan melalui penyediaan laporan hasil kegiatan yang jujur, objektif, dan berbasis bukti ilmiah (*evidence-based*)
- e. Keberlanjutan operasional teknologi dengan menjamin bahwa rekomendasi yang diberikan mempertimbangkan kesiapan sumber daya manusia dan sarana prasarana

(4) Wewenang

- a. Pengaturan penilaian alat kesehatan melalui otoritas penuh untuk mengatur jadwal, melaksanakan pengkajian, dan memvalidasi laporan tentang alat kesehatan di rumah sakit
- b. Penentuan mitra bestari (*peer group*) dengan memilih ahli atau pakar yang kompeten sebagai panel penilai untuk melakukan tinjauan sejawat terhadap teknologi tertentu
- c. Koordinasi tim ahli dalam mengajukan permohonan rekomendasi teknis kepada pihak eksternal atau spesialis terkait guna memperkuat hasil kajian
- d. Akses data teknis dan klinis untuk meminta informasi mendalam mengenai spesifikasi alat, hasil uji klinis, maupun data penggunaan alat dari unit-kerja terkait

BAB VIII TENAGA MEDIS FUNGSIONAL

Pasal 71

- (1) Kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional
- (2) Pelaksana diagnosis, pengobatan, pencegahan komplikasi, peningkatan, dan pemulihan kesehatan
- (3) Pemberi penyuluhan kesehatan serta informasi medis kepada pasien dan keluarga
- (4) Penyelenggara pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi kedokteran
- (5) Pengguna pendekatan tim melalui kolaborasi aktif dengan berbagai tenaga profesi kesehatan terkait
- (6) Penanggung jawab pelayanan medis yang berada di bawah koordinasi Komite Medik
- (7) Penyusun standar prosedur operasional dan protokol klinis sesuai bidang spesialisasi masing-masing
- (8) Pemegang kewenangan klinis sah yang ditetapkan melalui surat penugasan dari direktur rumah sakit

BAB IX INSTALASI

Pasal 72

- (1) Pembentukan Instalasi sesuai kebutuhan rumah sakit untuk penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan
- (2) Struktur organisasi yang terbagi dalam tiga unsur utama yaitu pelayanan medis, penunjang medis, dan Bagian Umum
- (3) Unsur pelayanan medis yang mencakup Rawat Jalan, Rawat Inap, Gawat Darurat, ICU, dan Kamar Operasi
- (4) Unsur penunjang medis yang terdiri dari Radiologi, Farmasi, Laboratorium, Rekam Medis, CSSD dan Gizi
- (5) Unsur Bagian Umum yang meliputi IPSRS,
- (6) Penerapan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan cross functional approach secara vertikal maupun horizontal dalam tata kerja
- (7) Mekanisme kerja yang selaras antar instalasi sesuai dengan tugas masing-masing unit
- (8) Penetapan pembentukan instalasi secara resmi melalui keputusan Direktur

BAB X KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 73

- (1) Komposisi tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan sesuai bidang keahlian masing-masing
- (2) Penentuan jumlah tenaga fungsional berdasarkan analisis kebutuhan dan beban kerja nyata di rumah sakit
- (3) Pelaksanaan tugas dan kegiatan mandiri sesuai dengan jabatan fungsional serta keahlian yang dimiliki
- (4) Kepatuhan operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan profesi

- (5) Penetapan jenis dan jenjang jabatan fungsional yang mengacu pada regulasi pemerintah serta standar profesi
- (6) Penempatan tenaga fungsional di lingkungan unit kerja rumah sakit yang relevan dengan kompetensinya
- (7) Pengembangan karier dan profesionalisme tenaga fungsional secara terarah dalam struktur organisasi rumah sakit
- (8) Kontribusi aktif dalam peningkatan mutu pelayanan medis dan non-medis melalui keahlian spesifik

BAB XI PENGELOLAAN SUMBER DAYA

Pasal 74 Tujuan Pengelolaan

- (1) Pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai seluruh aspek Sumber Daya Manusia di organisasi
- (2) Orientasi utama pada pemenuhan kebutuhan pegawai secara kuantitatif melalui perencanaan jumlah yang tepat
- (3) Fokus pada aspek kualitatif melalui pengembangan kompetensi dan keahlian setiap individu
- (4) Dukungan strategis untuk pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien
- (5) Implementasi sistem manajemen yang terukur untuk menjamin produktivitas kerja
- (6) Penyelarasan kemampuan personel dengan visi dan misi jangka panjang lembaga
- (7) Penjaminan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan

Pasal 75 Pengangkatan Pegawai

- (1) Pelaksanaan pengangkatan pegawai yang berasal dari tenaga kontrak berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis
- (2) Fokus pada peningkatan produktivitas kerja guna menjamin mutu pelayanan rumah sakit
- (3) Mekanisme transisi status kepegawaian yang dilakukan secara transparan dan terukur
- (4) Pemenuhan standar kualifikasi sesuai dengan kebutuhan formasi di setiap unit kerja
- (5) Kepatuhan penuh terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (6) Proses seleksi dan penetapan yang mengacu pada kebijakan internal serta regulasi ketenagakerjaan

Pasal 76 Perpindahan Pegawai

- (1) Pelaksanaan mutasi atau rotasi di lingkungan rumah sakit dengan orientasi pada peningkatan kinerja organisasi
- (2) Sarana pengembangan karier pegawai melalui penyegaran tugas dan tanggung jawab baru
- (3) Penyesuaian penempatan kerja yang selaras dengan latar belakang pendidikan serta keterampilan teknis

- (4) Pertimbangan masa bakti pegawai pada unit kerja tertentu untuk menjaga dinamika operasional
- (5) Pemanfaatan pengalaman tugas sebelumnya sebagai nilai tambah dalam posisi yang baru
- (6) Dukungan terhadap struktur jenjang karier pegawai secara berkelanjutan dan terencana
- (7) Penilaian aspek kondisi fisik serta psikis pegawai guna menjamin produktivitas dan keselamatan kerja
- (8) Implementasi kebijakan perpindahan yang transparan sesuai dengan kebutuhan strategis rumah sakit

Pasal 77
Pemberhentian Pegawai

- (1) Pelaksanaan pemberhentian pegawai berstatus kontrak maupun tetap berdasarkan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku
- (2) Pengakhiran hubungan kerja secara otomatis bagi pegawai yang meninggal dunia
- (3) Pemutusan hubungan kerja atas dasar permintaan sendiri atau pengunduran diri secara sukarela
- (4) Penetapan batas usia pensiun pegawai pada usia 56 tahun sebagai dasar pemberhentian hormat
- (5) Penyesuaian jumlah personel akibat kebijakan perampingan struktur organisasi rumah sakit
- (6) Pemberhentian bagi pegawai yang dinyatakan tidak cakap secara jasmani maupun rohani berdasarkan penilaian medis
- (7) Mekanisme penyelesaian hak-hak pegawai pasca pemberhentian sesuai aturan internal dan undang-undang
- (8) Pendokumentasian administrasi pemberhentian secara tertib dalam catatan kepegawaian

BAB XII
KERAHASIAAN INFORMASI MEDIS

Pasal 78
Kerahasiaan Pasien

- (1) Setiap pegawai rumah sakit wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi mengenai pasien.
- (2) Pemberian informasi medis terkait kerahasiaan pasien hanya dapat dilakukan atas persetujuan Direktur atau Kepala Bidang Pelayanan.
- (3) Akses terhadap data medis pasien dibatasi hanya untuk kepentingan pelayanan atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- (4) Pelanggaran terhadap kerahasiaan informasi pasien akan dikenakan sanksi sesuai peraturan internal rumah sakit.

Pasal 79
Informasi Medis

- (1) Hak pasien mengacu sepenuhnya pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- (2) Setiap pasien berhak menerima informasi medis yang jujur dan benar mencakup keadaan kesehatan terkini.

- (3) Penjelasan mengenai rencana terapi serta berbagai alternatif tindakan medis yang tersedia wajib disampaikan kepada pasien.
- (4) Informasi harus mencakup manfaat dan risiko dari setiap alternatif tindakan yang akan diambil.
- (5) Pasien berhak mengetahui prognosis serta kemungkinan komplikasi yang dapat terjadi selama masa perawatan.

Pasal 80
Hak dan Kewajiban Pasien

- (1) Hak pasien meliputi:
 - a. Mendapatkan informasi mengenai Kesehatan dirinya;
 - b. Mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai Pelayanan Kesehatan yang diterimanya;
 - c. Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu;
 - d. Menolak atau menyetujui tindakan medis, kecuali untuk tindakan medis yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit menular dan penanggulangan KLB atau Wabah;
 - e. Mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medis;
 - f. Meminta pendapat Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan lain;
 - g. Mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Kewajiban Pasien meliputi :
 - a. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
 - b. Mematuhi nasihat dan petunjuk tenaga medis dan tenaga kesehatan;
 - c. Mematuhi ketentuan yang berlaku pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - d. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Pasal 81
Hak dan Kewajiban Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

- (1) Hak Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
 - a. Mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan Kesehatan Pasien;
 - b. Mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari Pasien atau keluarganya;
 - c. Mendapatkan gaji/upah, imbalan jasa, dan tunjangan kinerja yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mendapatkan perlindungan atas keselamatan, Kesehatan kerja, dan keamanan;
 - e. Mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya;
 - g. Mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui pengembangan kompetensi, keilmuan, dan karier di bidang keprofesiannya;
 - i. Menolak keinginan Pasien atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, kode etik, atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. Mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- k. Tenaga medis dan Tenaga Kesehatan dapat menghentikan Pelayanan Kesehatan apabila memperoleh perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f, termasuk tindakan kekerasan, pelecehan dan perundungan.
- (2) Kewajiban Dokter meliputi :
- a. Memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan Kesehatan Pasien;
 - b. Memperoleh persetujuan dari Pasien atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;
 - c. Menjaga rahasia Kesehatan Pasien;
 - d. Membuat dan menyimpan catatan dan/ atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan; dan
 - e. Merujuk Pasien ke Tenaga Medis atau tenaga kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai.

Pasal 82

Hak dan Kewajiban Rumah Sakit

- (1) Hak Rumah Sakit meliputi:
- a. Menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi dan kebutuhan pelayanan Rumah Sakit.
 - b. Menerima imbalan jasa pelayanan serta menetapkan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pengembangan pelayanan, pendidikan, dan penelitian.
 - d. Menerima bantuan atau hibah dari pihak lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
 - e. Melakukan tuntutan hukum/menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian bagi Rumah Sakit.
 - f. Mendapatkan perlindungan hukum dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
 - g. Mempromosikan layanan kesehatan secara jujur dan informatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban Rumah Sakit meliputi:
- a. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat.
 - b. Menyenggarakan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien.
 - c. Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien tanpa meminta uang muka terlebih dahulu.
 - d. Melaksanakan fungsi sosial dengan menyediakan fasilitas untuk pasien tidak mampu, pelayanan korban bencana, dan misi kemanusiaan lainnya.
 - e. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan yang layak, termasuk ruang ibadah, parkir, ruang tunggu, serta fasilitas ramah disabilitas, lansia, anak, dan ibu menyusui.
 - f. Menyenggarakan rekam medis secara elektronik dan terintegrasi sesuai standar nasional.
 - g. Melaksanakan sistem rujukan yang terpadu dan efisien.
 - h. Menolak permintaan pasien atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, etika, dan peraturan perundang-undangan.

- i. Menghormati, melindungi, dan memberikan informasi yang jelas mengenai hak serta kewajiban pasien.
- j. Menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws).
- k. Melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi seluruh petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas kedinasan.
- l. Menyelenggarakan sistem pencegahan kecelakaan, penanggulangan bencana, dan keselamatan kerja.
- m. Mendukung dan melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan, baik skala regional maupun nasional.
- n. Membuat daftar tenaga medis dan tenaga kesehatan yang melakukan praktik di Rumah Sakit.
- o. Menetapkan seluruh area Rumah Sakit sebagai kawasan tanpa rokok dan bebas asap rokok.

BAB XIII KEBIJAKAN, PEDOMAN DAN PROSEDUR

Pasal 83

- (1) Kebijakan merupakan regulasi tertinggi di rumah sakit yang diikuti oleh Pedoman atau Panduan dan selanjutnya Standar Prosedur Operasional sebagai acuan utama pelaksanaan kegiatan.
- (2) Proses evaluasi dan persetujuan ulang dokumen regulasi dilakukan minimal setiap 3 tahun sekali atau jika terdapat perubahan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Identifikasi terhadap perubahan regulasi dilakukan oleh unit pelaksana secara berjenjang sesuai dengan hierarki struktural organisasi.
- (4) Dokumen regulasi harus diletakkan di tempat yang mudah dilihat dan diakses oleh pelaksana untuk menjamin kelancaran operasional di lapangan.

BAB XIV KERJASAMA/ KONTRAK

Pasal 84

- (1) Direktur Rumah Sakit menjamin keberlangsungan pelayanan klinis dan manajemen melalui perjanjian kerja sama atau kontrak yang memenuhi kebutuhan pasien.
- (2) Para pihak dapat memprakarsai rencana kerja sama yang kemudian dituangkan dalam rancangan kontrak dengan memuat subjek, objek, ruang lingkup, hak dan kewajiban, jangka waktu, pengakhiran kontrak, keadaan memaksa, serta penyelesaian perselisihan.
- (3) Materi perjanjian dikoreksi dan disetujui melalui pembubuhan paraf oleh pejabat berwenang sesuai dengan hierarki dan bidang masing-masing.
- (4) Kontrak klinis diajukan secara berjenjang oleh unit pelayanan dengan partisipasi serta tanggung jawab Kepala Bidang Pelayanan.
- (5) Kerja sama klinis dapat dilakukan antara rumah sakit dengan individu staf klinis melalui pakta integritas maupun dengan badan hukum untuk penyediaan jenis pelayanan tertentu.
- (6) Kontrak manajemen diajukan oleh unit administrasi dengan partisipasi serta tanggung jawab Kepala Bidang Penunjang serta Kepala Bidang Umum dan Keuangan, termasuk kerja sama alat kesehatan (KSO) dan pelayanan non-klinis.

- (7) Dokumen yang telah diparaf oleh kedua belah pihak diberikan penomoran resmi dan mencantumkan klausul pengalihan tanggung jawab kepada pihak kedua.
- (8) Penandatanganan kontrak dilakukan oleh Direktur Rumah Sakit dan pihak rekanan di atas meterai yang cukup sesuai ketentuan berlaku.
- (9) Hasil kerja sama dapat berupa aset material seperti uang dan barang, maupun non-material berupa hasil pelayanan kesehatan, pengobatan, laboratorium, dan jasa lainnya.
- (10) Seluruh pendapatan berupa uang wajib dicatat sebagai pendapatan rumah sakit, sedangkan hasil berupa barang wajib dicatat sebagai aset rumah sakit secara proporsional.
- (11) Evaluasi kerja sama dilakukan oleh unit pelaksana secara berjenjang dan dimonitoring mutunya oleh Komite Mutu Rumah Sakit.
- (12) Jika hasil evaluasi menunjukkan pelayanan tidak sesuai kontrak, Komite Mutu berwenang menyarankan pemberian teguran hingga pemutusan kontrak.
- (13) Review kontrak untuk perpanjangan atau negosiasi ulang dapat dilakukan guna menjaga kontinuitas pelayanan kepada pasien.

BAB XV PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 85 Perencanaan

- (1) Rumah Sakit menyusun Rencana Strategis (Renstra) Bisnis Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo sebagai panduan operasional jangka panjang.
- (2) Renstra Bisnis mencakup visi, misi, program strategis, pengukuran kinerja, rencana pencapaian lima tahunan, serta proyeksi keuangan lima tahunan.
- (3) Visi memuat gambaran masa depan dan cita-cita ideal yang ingin diwujudkan oleh Rumah Sakit.
- (4) Misi memuat langkah-langkah strategis yang harus dilaksanakan untuk mencapai visi sesuai dengan bidang pelayanan kesehatan.
- (5) Program strategis berisi rangkaian kegiatan berorientasi hasil untuk kurun waktu satu hingga lima tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, serta kendala.
- (6) Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan menggambarkan hasil kegiatan disertai analisis faktor internal dan eksternal yang memengaruhi keberhasilan.
- (7) Rencana pencapaian lima tahunan memuat target capaian kinerja pelayanan tahunan secara terukur selama periode lima tahun.
- (8) Proyeksi keuangan lima tahunan memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan untuk menjamin stabilitas dan keberlanjutan ekonomi Rumah Sakit.

Pasal 86 Penggangan

- (1) Rumah Sakit menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan dengan berpedoman pada Rencana Strategis Bisnis yang telah ditetapkan.
- (2) Penyusunan RBA dilakukan berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja guna memastikan efektivitas penggunaan sumber daya.
- (3) Anggaran disusun melalui perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan untuk mencerminkan biaya satuan yang akurat.
- (4) Rencana pendanaan harus mempertimbangkan kebutuhan operasional serta proyeksi kemampuan pendapatan dari masyarakat, badan hukum lain, dan sumber pendapatan sah lainnya.

Pasal 87
Rencana Bisnis Anggaran

- (1) Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit memuat laporan kinerja tahun berjalan serta analisis asumsi makro dan mikro.
- (2) Dokumen tersebut menetapkan target kinerja dan melakukan analisis serta perkiraan biaya satuan sebagai dasar operasional.
- (3) Penyusunan anggaran mencakup perkiraan harga, anggaran pendapatan dan biaya, serta penetapan besaran persentase ambang batas.
- (4) RBA menyajikan prognosis laporan keuangan, perkiraan maju (forward estimate), dan rencana pengeluaran investasi atau modal.
- (5) Rencana Bisnis dan Anggaran wajib disertai dengan usulan program, rencana kegiatan, Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta rincian biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 88
Persetujuan

- (1) Rencana Strategis (Renstra) Bisnis Rumah Sakit wajib mendapatkan persetujuan dari Representasi Pemilik sebagai dasar utama penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran serta instrumen evaluasi kinerja.
- (2) Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) harus disetujui oleh Representasi Pemilik dan berfungsi sebagai penjabaran operasional dari seluruh program serta kegiatan rumah sakit dengan tetap berpedoman pada prinsip pengelolaan keuangan yang berlaku.

BAB XVI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN KINERJA

Pasal 89
Pembinaan dan Pengawasan

- (1) Direktur PT Disa Prima Medika bertanggung jawab penuh atas pembinaan teknis serta pembinaan keuangan Rumah Sakit.
- (2) Satuan Pemeriksa Internal menjalankan fungsi audit internal untuk pengawasan operasional dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Rumah Sakit.
- (3) Representasi Pemilik turut serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Rumah Sakit bersinergi dengan Direktur PT Disa Prima Medika serta Auditor Internal.

Pasal 90
Evaluasi dan Penilaian Kinerja

- (1) Visi dan misi merupakan pedoman utama dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, serta penilaian kinerja Rumah Sakit.
- (2) Peninjauan atau perubahan visi dan misi dilakukan apabila terdapat perubahan kebijakan dari pemilik Rumah Sakit.
- (3) Direktur Rumah Sakit mengajukan usulan perubahan visi dan misi kepada Direktur PT Disa Prima Medika berdasarkan hasil rapat Tim Evaluasi Visi dan Misi.
- (4) Pengesahan visi dan misi dilakukan melalui Keputusan Direktur dan wajib dipublikasikan oleh Humas Rumah Sakit.
- (5) Direktur PT Disa Prima Medika melakukan evaluasi serta penilaian kinerja tahunan yang mencakup aspek keuangan dan non-keuangan.
- (6) Evaluasi kinerja bertujuan mengukur tingkat keberhasilan pengelolaan Rumah Sakit sesuai dengan target dalam Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis Anggaran.

- (7) Hasil pengukuran kinerja wajib dilaporkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi dan disampaikan kepada Direktur.

BAB XVII STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 91 Standar Pelayanan Minimal

- (1) PT Disa Prima Medika menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan medik, keperawatan, serta umum di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo .
- (2) Penyusunan Standar Pelayanan Minimal dilakukan berdasarkan usulan dari Direksi PT Disa Prima Medika dan manajemen Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo .
- (3) Penetapan Standar Pelayanan Minimal wajib mempertimbangkan kualitas layanan, status akreditasi, pemerataan, kesetaraan akses, serta kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.

Pasal 92 Syarat Standar Pelayanan Minimal

- (1) Standar Pelayanan Minimal berfokus pada jenis pelayanan yang mengutamakan kegiatan penunjang terwujudnya tugas dan fungsi utama Rumah Sakit.
- (2) Standar Pelayanan Minimal harus terukur sehingga pencapaian kinerjanya dapat dinilai secara objektif sesuai standar yang telah ditetapkan.
- (3) Standar Pelayanan Minimal harus dapat dicapai melalui kegiatan nyata, rasional, serta dapat dihitung tingkat keberhasilannya sesuai dengan kemampuan dan tingkat pemanfaatan sumber daya.
- (4) Standar Pelayanan Minimal harus relevan dan dapat diandalkan agar selalu sejalan dan berkaitan dalam menunjang tugas serta fungsi organisasi secara konsisten.
- (5) Standar Pelayanan Minimal harus tepat waktu yang berarti terdapat kesesuaian antara jadwal pelaksanaan dengan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

BAB XVIII TARIF LAYANAN

Pasal 93

- (1) Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang atau jasa layanan kesehatan yang diberikan.
- (2) Imbalan tersebut ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun berdasarkan perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil investasi dana.
- (3) Tarif merupakan imbalan hasil yang wajar dari investasi biaya per unit layanan yang telah dikeluarkan oleh Rumah Sakit.
- (4) Tarif layanan dapat berupa besaran angka nominal tertentu atau pola tarif yang disesuaikan dengan jenis layanan di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.

Pasal 94 Penetapan Tarif Layanan

- (1) Direktur mengusulkan tarif layanan Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo kepada Direktur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tarif layanan tersebut ditetapkan secara resmi melalui peraturan perusahaan.

- (3) Penetapan tarif dilakukan dengan mempertimbangkan kesinambungan pelayanan, pengembangan layanan masyarakat, serta kompetisi yang sehat di bidang kesehatan.
- (4) Dalam menetapkan besaran tarif, Direktur dapat membentuk Tim Tarif Pelayanan untuk melakukan kajian yang komprehensif.
- (5) Tim Tarif Pelayanan sekurang-kurangnya terdiri dari unsur Keuangan, Pelayanan Medis, Pelayanan Penunjang Medis, Bagian Umum, serta perwakilan dari PT Disa Prima Medika.

Pasal 95
Perubahan Tarif Layanan

- (1) Perubahan tarif layanan Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan operasional dan perkembangan keadaan ekonomi atau medis.
- (2) Perubahan tarif tersebut dapat dilakukan secara menyeluruh untuk semua jenis layanan maupun secara parsial per unit layanan tertentu.
- (3) Proses perubahan tarif wajib berpedoman pada ketentuan dan mekanisme penetapan tarif layanan yang telah ditetapkan oleh rumah sakit.

BAB XIX
TUNTUTAN UMUM

Pasal 96

- (1) Penanganan hukum bagi pegawai Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yang menghadapi tuntutan pidana dilaksanakan berdasarkan jenis tuntutan yang diajukan.
- (2) Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo bertanggung jawab penuh atas tuntutan hukum yang berkaitan dengan institusi, selama pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai dengan aturan dan Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berlaku.
- (3) Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo tidak bertanggung jawab atas tuntutan hukum yang bersifat personal atau individu jika kesalahan tersebut terjadi akibat pengabaian terhadap aturan atau Standar Prosedur Operasional (SPO) yang telah ditetapkan.

BAB XX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 97

- (1) Direktur menetapkan struktur, nama, jumlah, dan fungsi satuan organisasi fungsional lain yang belum tercantum dalam Hospital Bylaws melalui Keputusan Direktur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap perubahan terkait struktur, nama, jumlah, serta fungsi satuan organisasi fungsional di lingkungan Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 98
Penutup

- (1) Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) yang mencakup Corporate Bylaws dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam kebijakan, pedoman, atau Standar Prosedur Operasional (SPO) rumah sakit.
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan ini diatur oleh Direktur Rumah Sakit sesuai kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (5) Hasil evaluasi dapat menjadi dasar perubahan atau penyempurnaan *Hospital By Laws*

Ditetapkan di Malang,
Pada tanggal 15 Desember 2024
Direktur Perseroan Terbatas
Disa Prima Medika



dr. Sefrina Trisadi, Sp. DVE